

Correzione commentata

Test SSM
2023





TEST SSM 2023 - CORREZIONI COMMENTATE

In questo documento, per tutti i quesiti proposti la soluzione è l'opzione A > **se vuoi metterti alla prova, trovi il test SSM 23 con risposte rimescolate sul nostro [simulatore](#) a partire dalla prossima settimana!**

DOMANDE TEST SSM 2023

Domanda 1: (codice domanda: ssm2023441)

Un ragazzo di 28 anni con stenosi valvolare aortica severa viene avviato alla sostituzione valvolare aortica in ministernotomia.

L'intervento viene eseguito con un'incisione:

- A: Del tratto craniale dello sterno a forma di J, al III o IV spazio intercostale dx
- B: Trasversale del tratto caudale dello sterno
- C: Del tratto caudale dello sterno a forma di T
- D: Medio-ascellare sx al V spazio intercostale
- E: Medio-ascellare dx al V spazio intercostale

CC: La ministernotomia permette la sostituzione valvolare aortica chirurgica evitando una sternotomia mediana completa. Ciò si associa ad un ridotto periodo di degenza, un ridotto trauma operatorio e un rischio inferiore di complicanze legate all'accesso chirurgico. L'incisione viene eseguita dal tratto craniale del manubrio dello sterno fino al III o più raramente IV spazio intercostale destro e permette di esporre l'aorta ascendente per la sostituzione valvolare.

Difficoltà: Facile

Domanda 2: (codice domanda: ssm2023442)

Lo pneumotorace NON è in genere associato a:

- A: Lacerazione esofagea non iatrogena
- B: Rottura di blebs subpleuriche polmonari
- C: Rottura di bolle enfisematose polmonari
- D: Manovra invasive di diagnostica pleuropolmonare
- E: Trauma toracico trafittivo

CC: Lo pneumotorace è una condizione patologica caratterizzata dalla presenza di aria nel cavo pleurico. determinando un collasso parziale o completo del polmone. L'opzione B, C, D ed E sono tutte condizioni (e tra le cause più comuni) che possono



provocare lo scollamento del floglietto pleurico e determinare PNX. La lacerazione esofagea invece, non è in genere associata a PNX. Risposta corretta A.

Difficoltà: Facile

Domanda 3: (codice domanda: ssm2023443)

Un paziente di 30 anni con sindrome di Marfan giunge in ospedale con una dissezione aortica di tipo B. Quando è indicato l'intervento chirurgico?

- A: Se sono presenti segni clinici e radiologici di malperfusion e/o rottura imminente
- B: Se il vero lume è più grande del falso lume
- C: Se il falso lume è trombizzato
- D: Se l'aorta misura tra 30 e 35 mm di diametro
- E: Se tutti i vasi viscerali nascono dal vero lume

CC: La dissezione aortica di tipo Stanford B (senza coinvolgimento dell'aorta ascendente) non prevede normalmente l'approccio chirurgico o interventistico, indipendentemente dal fatto che il paziente abbia una collagenopatia come la sindrome di Marfan. Infatti, la terapia medica non ha dimostrato inferiorità in termini prognostici ed è quindi indicata in prima linea. Tuttavia, nel caso in cui si tratti di una dissezione complicata da malperfusion d'organo (dovuta al coinvolgimento dei vasi viscerali collaterali dell'aorta discendente) o segni radiologici di rottura, è indicato sia nelle linee guida AHA che ESC l'intervento in open o per via endovascolare (approccio da scegliere in base al caso specifico).

Difficoltà: Facile

Domanda 4: (codice domanda: ssm2023444)

Quali sono le arterie che nascono dall'arco dell'aorta in assenza di varianti anatomiche?

- A: Tronco anonimo, carotide sx e succlavia sx
- B: Tronco anonimo, carotide dx, vertebrale sx e succlavia dx
- C: Succlavia dx, carotide sx e carotide dx
- D: Tronco anonimo, carotide dx e succlavia sx
- E: Vertebrale dx, carotide dx e succlavia sx

CC: Domanda di anatomia di base. Dall'arco aortico nascono, in ordine prossimo-distale, il tronco anonimo o arteria branchiocefalica, la carotide di sinistra e la succlavia di sinistra. Esistono tuttavia numerose varianti anatomiche, che la domanda specificava di non prendere in considerazione.

Difficoltà: Facile



Domanda 5: (codice domanda: ssm2023445)

Giunge in ambulatorio un paziente con diagnosi di acromegalia. Quale delle seguenti condizioni è atipica nel paziente acromegalico?

- A: Ipoglicemia
- B: Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare
- C: Sindrome da intrappolamento del nervo mediano al polso
- D: Iperprolattinemia
- E: Ipertensione

CC: L'acromegalia è una patologia legata ad un aumento della produzione dell'ormone della crescita (GH); nel 90% dei casi è causata da un adenoma ipofisario. Spesso l'iperproduzione di GH è associata ad una iperproduzione di prolattina (adenomi GH/PRL-secernti) oppure vi può essere una iperprolattinemia legata alla presenza di un macroadenoma ipofisario che disloca il peduncolo determinando un'iperprolattinemia da deconnessione (opzione D esatta, pertanto da escludere, in quanto la domanda chiede una condizione ATIPICA dell'acromegalia).

Nell'adulto l'ipersecrezione di GH determina una sindrome definita acromegalia, caratterizzata dall'aumento delle dimensioni dei tessuti molli delle mani e dei piedi (pertanto vi è la necessità di aumentare le dimensioni di scarpe ed anelli) e degli organi interni; si osserva una modificazione dell'aspetto del volto, con prognatismo, diastasi dentaria, e macroglossia, iperseborrea e visceromegalia (in particolare a carico di tiroide, prostata e cuore, con lo sviluppo di ipertrofia cardiaca associata ad ipertensione; escludiamo pertanto l'opzione E, esatta). Altre manifestazioni comuni sono le neuropatie periferiche, in particolare la sindrome del tunnel carpale, spesso bilaterale, e che sono determinate dalla compressione dei nervi conseguente alla proliferazione dei tessuti molli (escludiamo dunque le opzioni B e C, esatte).

L'aumento cronico del GH determina effetti anti-insulinici, con inibizione della captazione e dell'utilizzo del glucosio, IPERGLICEMIA e ridotta tolleranza al glucosio, con aumento del rischio di sviluppare diabete mellito. Pertanto, la condizione ATIPICA dell'acromegalia è l'ipoglicemia (opzione A).

Difficoltà: Facile

Domanda 6: (codice domanda: ssm2023446)

Giunge all'osservazione un paziente di 49 anni con emangioblastoma cerebellare. In anamnesi, il paziente ha storia di feocromocitoma, cisti pancreatica e carcinoma a cellule renali. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Sindrome di Von Hippel-Lindau



B: MEN1

C: MEN2

D: Complesso della sclerosi tuberosa

E: Neurofibromatosi Tipo 1

CC: La malattia di Von Hippel-Lindau (VHL) è una sindrome con predisposizione familiare al cancro, legata a neoplasie benigne e maligne, come gli emangioblastomi della retina, del cervelletto e del midollo spinale, il carcinoma delle cellule renali (RCC) e il feocromocitoma. La presenza di emangioblastomi doveva subito farci escludere le MEN, e l'assenza di sintomi tipici doveva farci escludere la sclerosi tuberosa e la neurofibromatosi.

Difficoltà: Difficile

Domanda 7: (codice domanda: ssm2023447)

Una donna di 45 anni miope si reca al Pronto Soccorso lamentando visione offuscata in un occhio, fotopsie (flash luminosi) e miodesopsie (mosche e ragnatele) con la comparsa di un'ombra in una zona del campo visivo che si estende progressivamente. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

A: Distacco di retina

B: Glaucoma

C: Neurite ottica acuta

D: Congiuntivite batterica

E: Degenerazione maculare senile

CC: Il caso clinico presentato ha tutte le caratteristiche tipiche del distacco di retina. La presenza di fotopsie e miodesopsie è in comune con tutte le patologie retiniche di tipo regmatogeno come rotture retiniche e trazioni vitreali. La presenza aggiunta di aree nere di campo visivo come una "tendina" che si apre e che si chiude è il sintomo patognomonico del distacco di retina. L'offuscamento e il calo visus acuto completano il quadro differenziando dalle patologie croniche come il glaucoma, la degenerazione maculare senile.

Difficoltà: Facile

Domanda 8: (codice domanda: ssm2023448)

Il glaucoma è:

A: Una otticopatia progressiva

B: Una neoplasia oculare benigna



- C: Una neoplasia oculare maligna
- D: Una neoplasia del nervo ottico
- E: Una degenerazione retinica

CC: Il glaucoma non è una neoplasia. È una patologia degenerativa cronica multifattoriale a carico del nervo ottico.

Difficoltà: Facile

Domanda 9: (codice domanda: ssm2023449)

Un uomo di 57 anni accusa diplopia orizzontale binoculare. La visione doppia peggiora nello sguardo verso destra. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile:

- A: Paralisi isolata del VI nervo cranico di destra
- B: Paralisi isolata del VI nervo cranico di sinistra
- C: Paralisi isolata del IV nervo cranico di sinistra
- D: Paralisi isolata del IV nervo cranico di destra
- E: Paralisi completa del III nervo cranico di destra

CC: La diplopia che peggiora con i movimenti dello sguardo ha una causa neuromuscolare. Uno dei muscoli estrinseci dell'occhio non sta funzionando correttamente e dunque non permette l'allineamento degli assi visivi in tutte le direzioni. Se la diplopia peggiora guardando verso destra sul piano orizzontale il muscolo coinvolto sarà il retto laterale di destra innervato dal VI nervo cranico di destra.

Difficoltà: Facile

Domanda 10: (codice domanda: ssm2023450)

Quale nervo innerva il muscolo cricotiroideo?

- A: Nervo laringeo superiore
- B: Nervo laringeo ricorrente
- C: Nervo glossofaringeo
- D: Nervo laringeo medio
- E: Nervo ipoglosso

CC: A occuparsi dell'innervazione sensitiva e motoria (cioè dei muscoli) della laringe sono due branche del nervo vago (X nervo cranico), conosciute come nervo laringeo ricorrente e nervo laringeo superiore. Il muscolo cricotiroideo, a differenza degli altri muscoli laringei, è innervato dai rami motori del nervo laringeo superiore, ramo del nervo vago.

Difficoltà: Difficile



Domanda 11: (codice domanda: ssm2023451)

Un paziente di otto anni viene accompagnato al Pronto Soccorso per comparsa di tumefazione cervicale mediana anteriore, dolorabile ed iperemica. Agli atti deglutitori si apprezza rapporto con l'osso ioide. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Cisti del dotto tireoglosso
- B: Metastasi linfonodale
- C: Adenopatia suppurata
- D: Ranula
- E: Ascesso parafaringeo

CC: Quando si presenta una tumefazione cervicale del bambino dobbiamo pensare in primo luogo a patologie congenite o infiammatorie. La cisti mediana del collo, detta anche cisti del dotto tireoglosso, è una condizione congenita dovuta alla mancata chiusura di un dotto da cui si sviluppa la ghiandola tiroide. Quest'ultima infatti nasce da un abbozzo che è presente alla base della lingua (forame cieco) e che si porta in basso fino alla loggia tiroidea. Le altre caratteristiche sono descritte nel testo della domanda. L'Ascesso parafaringeo ha sia una sede che una sintomatologia differente: si presenta con trisma e/o dispnea e non genera una tumefazione sul collo. Le Metastasi linfonodali sono laterocervicali così come l'adenopatia suppurata. In più vista l'età del bambino escludiamo la presenza di un tumore primitivo delle VADS. Le adenopatie inoltre non sono in comunicazione con l'osso ioide. La Ranula è una raccolta di saliva della ghiandola sottolinguale che si trova al di sopra dello ioide ed è palpabile nel pavimento orale. Risposta corretta: cisti del dotto tireoglosso.

Difficoltà: Facile

Domanda 12: (codice domanda: ssm2023452)

Un paziente di 55 anni, sottoposto due anni prima a chirurgia implantare a livello dell'arcata alveolare superiore destra, lamenta dolore da giorni a livello facciale infraorbitario destro. L'esame endoscopico mostra edema e secrezioni purulente a carico del complesso ostio-meatale destro. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Sinusite odontogena etmoido-mascellare
- B: Nevralgia del trigemino
- C: Danno iatrogeno del nervo alveolare superiore
- D: Sinusite frontale
- E: Carcinoma del rinofaringe



CC: L'esame endoscopico suggerisce un coinvolgimento a carico del complesso ostio-meatale ovvero quella struttura anatomica che comprende gli osti di alcuni seni paranasali: seno mascellare, seno frontale e etmoidale anteriore. A questo livello si trovano secrezioni ed edema, segni di infezione. Sia per sede che per sintomatologia escludiamo quindi carcinoma del rinofaringe, nevralgia del trigemino (si presenta inoltre con crisi di dolore estese a tutto L emivolto) e danno del nervo alveolare superiore (il danno nervoso genera inoltre delle alterazioni della sensibilità e non si correla con processi infettivi). L'anamnesi del paziente suggerisce una correlazione del problema con il seno mascellare in quando questo si trova in comunicazione con le arcate alveolari, sede della chirurgia impiantare. Procedure di implantologia sono una delle cause di sinusite odontogena. Il dolore infraorbitario è un dolore facciale in corrispondenza del seno. Risposta corretta sinusite odontogena etmoido-mascellare.

Difficoltà: Facile

Domanda 13: (codice domanda: ssm2023453)

Un uomo di 76 anni giunge al Pronto Soccorso con un quadro clinico di ileo meccanico. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Carcinoma del colon
- B: Calcolosi della colecisti
- C: Appendicite
- D: Diverticolo perforato
- E: Megacolon tossico

CC: Per ileo meccanico si intende una grave condizione patologica, conosciuta altrimenti come occlusione intestinale, legata all'arresto della progressione della digestione del contenuto intestinale, liquido, solido o gassoso. In base alla causa si possono distinguere in ileo paralitico o dinamico, quando l'alterazione è funzionale e conseguente a una paralisi della muscolatura propria dell'intestino con blocco della peristalsi (tipico dell'infiammazione, quindi dell'appendicite) ed un ileo meccanico, in cui l'occlusione è dovuta a un ostacolo vero e proprio.

Difficoltà: Difficile

Domanda 14: (codice domanda: ssm2023454)

Ad un giovane di 30 anni vengono diagnosticati un feocromocitoma, aumento del paratormone ed un nodulo tiroideo positivo per carcinoma midollare. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile:

- A: MEN2A
- B: MEN1



- C: Tumore del polmone
- D: Iperaldosteronismo
- E: Tumore endocrino del pancreas

CC: Il paziente del caso clinico, peraltro di giovane età, presenta l'associazione di feocromocitoma, iperparatiroidismo e carcinoma midollare. Questo suggerisce la presenza di una sindrome associata alla formazione di neoplasie endocrine multiple, pertanto possiamo già escludere le opzioni C e D. Non ci sono inoltre elementi clinici che suggeriscano la presenza di un tumore endocrino del pancreas (ad esempio il rilievo di ipoglicemie nell'insulinoma), pertanto possiamo escludere anche l'opzione E.

La neoplasia endocrina multipla di tipo 1 (o MEN1) è una sindrome ereditaria caratterizzata da iperparatiroidismo primitivo - determinato nella maggior parte dei casi da un'iperplasia delle paratiroidi -, tumori neuroendocrini del pancreas (funzionanti o non) e/o adenomi ipofisari. Viene anche definita sindrome delle 3 P, da Parathyroid, Pancreas, Pituitary; più raramente possono essere presenti tumori carcinoidi, mentre raro è il riscontro di feocromocitoma.

La MEN2A, causata da mutazioni dell'oncogene RET, è invece caratterizzata dalla presenza di carcinoma midollare della tiroide (presente nel 90-100% dei casi), feocromocitoma (nel 40-50%) e, più raramente, adenomi/iperplasia delle paratiroidi. La MEN2B si presenta invece con carcinoma midollare della tiroide, feocromocitoma, neuromi multipli delle mucose ed un habitus marfanoide.

L'associazione tra carcinoma midollare della tiroide, feocromocitoma ed iperparatiroidismo si ritrova nella MEN2A, che rappresenta la risposta corretta alla domanda.

Difficoltà: Media

Domanda 15: (codice domanda: ssm2023455)

Un uomo di 55 anni affetto da molto tempo da disturbi dispeptici viene alla osservazione per una tumefazione della fossa clavicolare sinistra (Segno di Troisier). Qual è il sospetto diagnostico più verosimile tra i seguenti?

- A: Tumore dello stomaco
- B: Tumore del timo
- C: Tumore del colon
- D: Tumore della tiroide
- E: Gastrite cronica

CC: Il segno di Troisier è la presenza di tumefazione linfonodale sovraclaveare sinistra e può associarsi a tumore dello stomaco.

Difficoltà: Facile



Domanda 16: (codice domanda: ssm2023456)

Un uomo di 62 anni ha di recente sviluppato un diabete mellito con costante perdita di peso e dolore puntorio localizzato ai quadranti superiori dell'addome ed irradiato al dorso. Qual è il sospetto diagnostico più probabile tra i seguenti?

- A: Tumore del pancreas avanzato
- B: Tumore del retto
- C: Epatite cronica
- D: Diverticolosi
- E: Poliposi familiare

CC: La presenza di dolore in sede tipica (quadranti superiori ed irradiato al dorso), la perdita di peso e il diabete mellito suggeriscono l'etimologia pancreatica del quadro clinico. L'epatite cronica non dà dolore, la diverticolosi dà dolore soprattutto ai quadranti inferiori. Il tumore del retto e la poliposi familiare determinano in prima battuta occlusione intestinale ed anemizzazione.

Difficoltà: Facile

Domanda 17: (codice domanda: ssm2023457)

Un uomo di 45 anni è affetto da calcolosi della colecisti, diverticoli del colon, reflusso gastroesofageo. Quale nome si associa a quest'insieme di patologie?

- A: Triade di Saint
- B: Sindrome di Marfan
- C: Sindrome di Mallory-Weiss
- D: Sindrome di Lynch
- E: Sindrome di Peutz-Jeghers

CC: La triade di Saint è una triade sindromica caratterizzata da tre condizioni cliniche, quali: ernia iatale, Colelitiasi e diverticolosi del colon. La sindrome di Marfan è una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari. La lacerazione del tratto inferiore dell'esofago e della porzione superiore dello stomaco, durante un episodio di vomito violento, conati di vomito o singhiozzo, viene definita lacerazione di Mallory-Weiss. La sindrome di Lynch, nota anche come cancro coloretale ereditario non poliposico (hereditary nonpolyposis colon cancer or HNPCC), è una patologia ereditaria caratterizzata dall'aumentato rischio di sviluppare il carcinoma coloretale, il tumore dell'endometrio (utero) ed altri tipi di cancro. La sindrome di Peutz-Jeghers (PJS) è una rara malattia ereditaria, autosomica dominante caratterizzata dalla presenza di polipi benigni amartomatosi del tubo digerente associata ad una caratteristica pigmentazione



muco-cutanea presente dall'infanzia.

Difficoltà: Difficile

Domanda 18: (codice domanda: ssm2023458)

In un uomo di 75 anni affetto da molto tempo da dispepsia cronica resistente alla terapia, quale è tra le seguenti l'indagine diagnostica iniziale più appropriata?

A: Esofagogastroduodenoscopia con eventuale biopsia

B: RX Digerente

C: Clisma opaco a doppio contrasto

D: TC addome pelvi

E: RM addome

CC: Il testo ci chiede di approfondire una dispepsia cronica resistente alla terapia, quindi un sintomo legato all'upper GI: escludiamo quindi la C immediatamente, in quanto il clisma opaco a doppio contrasto, oltre che obsoleto come esame, ha come indicazione principale lo studio delle anse intestinali. La B poteva essere scartata in quanto l'RX digerente, nonostante ci dia delle informazioni funzionali che potrebbero comunque essere utili nell'iter diagnostico, non ha la stessa Sn e Sp dell'EGSD (risposta corretta A), la quale può inoltre andare ad indagare la presenza o meno dell'H. Pylori. La D e la E le potevamo scartare in quanto esami di secondo livello, usati solitamente per la successiva stadiazione o per la ricerca di ulteriori cause di dispepsia meno frequenti (oltre a non essere sicuramente le indagini INIZIALI più appropriate per uno studio dell'upper GI). Risposta corretta A.

Difficoltà: Facile.

Domanda 19: (codice domanda: ssm2023459)

Un uomo di 70 anni è affetto da adenocarcinoma del retto localizzato a 5 cm dal margine anale esterno, cT3N1M0. Quale delle seguenti strategie terapeutiche è la più appropriata?

A: Chemioradioterapia neoadiuvante, ristadiazione, chirurgia

B: Chemioterapia neoadiuvante, chirurgia

C: Chemioterapia e follow-up ad un anno

D: Chirurgia diretta

E: Radiofrequenza

CC: Siamo di fronte ad una domanda in cui si deve individuare la strategia giusta di trattamento per un tumore del retto localmente avanzata con iniziale coinvolgimento linfonodale. In questo caso sarà logico pensare ad una terapia neoadiuvante (effettuata cioè prima della chirurgia) con radioterapia (sempre utilizzata nei tumori del retto, a



differenza di quelli del colon) e chemioterapia seguita da ristadiatione e intervento chirurgico. L'opzione B per quanto sembri simile è errata in quanto non fa riferimento alla radioterapia e non parla di ristadiatione prima della chirurgia. Le altre opzioni da sole sono insufficienti per questo tipo di tumore a questo stadio.

Difficoltà: Media

Domanda 20: (codice domanda: ssm2023460)

Un uomo di 43 anni da un anno circa lamenta frequenti rigurgiti post-prandiali e notturni associati a disfagia ingravescente. Riferisce saltuario dolore toracico con valutazione cardiologica negativa. Esegue esofago-gastro-duodenoscopia negativa per lesioni neoplastiche ed esofagografia con contrasto per os di cui si allega il radiogramma. Alla luce dei reperti anamnestici e della radiografia quale è la diagnosi più verosimile tra le seguenti?



- A: Acalasia
- B: GIST del fondo gastrico
- C: Diverticolo epifrenico
- D: Malattia da reflusso gastroesofageo
- E: Ernia iatale sintomatica

CC: L'immagine proposta è quella di un RX transito digerente (con Bario o con Gastrografin) nella classica proiezione a 45 gradi circa, estremamente utile per

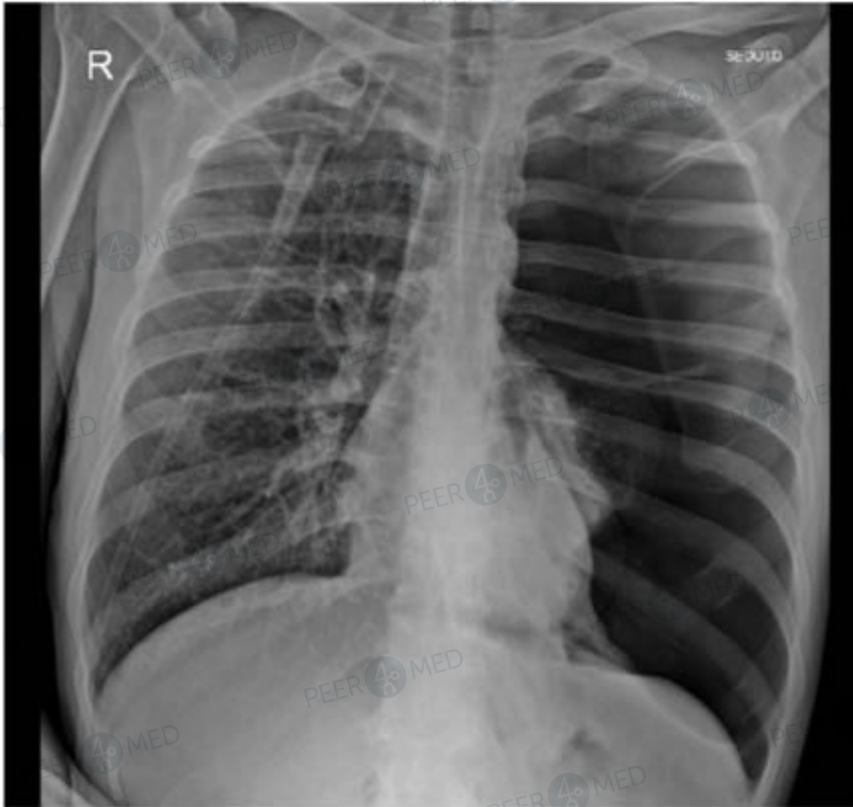


sproiettare l'esofago dalla via respiratoria e dalla colonna vertebrale. Vediamo la classica immagine "a coda di topo", patognomonica per l'acalasia (risposta corretta A) La D e la E, per quanto spesso associate, non sono la stessa cosa: nel primo caso avremmo semplicemente visto un ritorno di MdC anti-gravitario al passaggio cardias-stomaco, senza necessariamente tuttavia individuare la causa di tale reflusso; nella E viceversa avremmo visto sicuramente una porzione di stomaco o quando meno il cardias risalito oltre il profilo diaframmatico. Nella B invece, nel caso in cui la lesione fosse stata molto rilevata dalla mucosa gastrica, avremmo potuto vedere la classica immagine di "minus" (o il più delle volte niente, essendo l'esame molto poco Sn e Sp per questo tipo di lesioni); nella C invece avremmo visto una "doppia tasca", ovvero del MdC finire anche nella gola del diverticolo. Risposta corretta A.

Difficoltà: Media.

Domanda 21: (codice domanda: ssm2023461)

Paziente di 39 anni giunge in Pronto Soccorso per dolore toracico anteriore sinistro intensificato dagli atti respiratori. Alla valutazione clinica viene riscontrata tachipnea con 34 atti respiratori/minuto. All'esame obiettivo riduzione del murmure vescicolare sinistro. EGA (in area ambiente): pH 7.50, PaO₂ 62 mmHg, PaCO₂ 28 mmHg. Esegue RX del torace di cui si allega il radiogramma. Il quadro clinico, radiologico e emogasanalitico orienta per:



- A: Pneumotorace massivo sinistro meritevole di drenaggio toracico urgente
- B: Pneumotorace apicale sinistro meritevole di monitoraggio clinico strumentale
- C: Esteso focolaio bronco pneumonico sinistro meritevole di terapia antibiotica
- D: Severo quadro di scompenso cardiaco con edema polmonare meritevole di inquadramento e trattamento cardiologico urgente
- E: Versamento pleurico massivo sinistro meritevole di drenaggio toracico urgente

CC: Aldilà di tutte le informazioni cliniche estremamente utili (ma fuorvianti a volte) fornite dal testo, qui oggettivamente non c'è molto da dire: quello che si vede è una totale iperdiafania di tutto l'emitorace sinistro (leggi "più nero", quindi "più aria") ed un leggero shift controlaterale della colonna tracheale, indice di un PNx massivo, meritevole di drenaggio toracico (risposta corretta A); attenzione alla B, errata sia per il fatto che il PNx non è solo apicale e sia per il fatto che un PNx massivo necessiti di intervento immediato, al fine di non renderlo iperteso causando gravi problematiche cardio-respiratorie al Paziente. Nella C avremmo visto un'ipodiafania lobare (leggi "più bianco") tipico degli addensamenti polmonari; nella D avremmo visto un'ipodiafania ilare bilaterale dovuta all'edema; nella E avremmo visto il classico versamento pleurico ipodiafano con il classico segno del menisco.

Difficoltà: Facile.



Domanda 22: (codice domanda: ssm2023462)

Paziente giunge in Pronto Soccorso con dolore addominale associato a febbre con brivido ed ittero. Come si chiama l'associazione dei tre segni clinici presentati dal paziente?

- A: Triade di Charcot
- B: Triade di Reynolds
- C: Triade di Trousseau
- D: Triade di Calot
- E: Triade di Virchow

CC: La Triade di Charcot è un insieme di tre segni clinici che si riscontrano frequentemente nella colangite: ittero, febbre e dolore addominale. La sindrome di Paris-Trousseau (PTS) è una rara malattia ereditaria emorragica delle piastrine, caratterizzata da ritardo mentale, difetti cardiaci, anomalie facciali, associate a trombocitopenia e dismegacariopoiesi. Nel contesto delle patologie neurologiche, per "triade di Charcot" si intende la presenza di nistagmo, tremore intenzionale e parola scandita. Questa triade caratterizza il quadro clinico della sclerosi multipla. La triade di Virchow descrive quelli che sono considerati i principali fattori responsabili della formazione di trombi.

Difficoltà: Facile

Domanda 23: (codice domanda: ssm2023463)

In un neonato, l'atresia esofagea di III tipo è:

- A: La forma più frequente
- B: Secondaria ad esofago di Barrett
- C: Caratterizzata dalla presenza di una fistola tracheoesofagea prossimale
- D: Secondaria a reflusso gastroesofageo
- E: Secondaria ad ingestione accidentale di caustici

CC: L'atresia esofagea è un'incompleta formazione dell'esofago, frequentemente associata a fistola tracheoesofagea. Si classifica secondo Ladd e Gross in A) solo atresia B) atresia + fistola prossimale C) atresia + fistola distale (la più frequente) D) fistola distale più prossimale E) solo fistola. Risposta corretta A.

Difficoltà: Media

Domanda 24: (codice domanda: ssm2023464)

Qual è il sistema di classificazione più utilizzato per la contrattura capsulare periprotetica mammaria?



- A: Baker
- B: Allen
- C: Regnault
- D: Blondeel
- E: House Brackmann

CC: La scala di Baker è un metodo per la classificazione della contrattura capsulare periprotetica mammaria. La classificazione di Allen è quella più comunemente utilizzata per i traumi della colonna vertebrale. La classificazione di Regnault viene usata per la ptosi mammaria. Il sistema di classificazione del nervo facciale House-Brackmann è ampiamente utilizzato per caratterizzare il grado di paralisi facciale.

Difficoltà: Difficile

Domanda 25: (codice domanda: ssm2023465)

Una donna di 35 anni giunge presso l'ambulatorio di ginecologia riferendo amenorrea da circa 6 mesi, disturbi del sonno e dispareunia. I cicli negli anni precedenti sono sempre stati regolari per ritmo, durata e quantità. Porta in visione esami ormonali che evidenziano elevati valori di FSH e LH, bassi livelli di Estradiolo e Progesterone e null'altro di rilevante. La causa più probabile di amenorrea è:

- A: Menopausa prematura
- B: Adenoma ipofisario prolattino secernente
- C: Amenorrea da causa ipotalamica
- D: Amenorrea da causa ipofisaria
- E: Sindrome dell'ovaio policistico

CC: La paziente presenta valori elevati di FSH ed LH, questo ci può già far escludere cause ipofisarie ed ipotalamiche. Il testo non ci dà informazioni su sintomi dati da una iperprolattinemia, quindi possiamo escludere anche quest'altra opzione, ed infine non ha livelli elevati di estrogeni quindi escludiamo la PCOS in quanto nella PCOS si osservano un'aumentata produzione ovarica di androgeni e una maggiore trasformazione periferica (aromatizzazione) degli androgeni in estrogeni

Difficoltà: Media

Domanda 26: (codice domanda: ssm2023466)

Una gestante di 45 anni alla diciassettesima settimana di gravidanza, con bitest risultato ad alto rischio per un'elevata translucenza nucale, si sottopone ad amniocentesi. Il risultato del cariotipo fetale evidenzia una trisomia del cromosoma 13 che determina la seguente sindrome:



- A: Patau
- B: Down
- C: Edwards
- D: Klinefelter
- E: Turner

CC: Domanda mnemonica sulle principali aneuploidie. Trisomia 13 - sindrome di Patau. Trisomia 18 - sindrome di Edwards. Trisomia 21 - sindrome di Down. XXY - Sindrome di Klinefelter. XO - Sindrome di Turner.

Difficoltà: Facile

Domanda 27: (codice domanda: ssm2023467)

Giunge in ambulatorio di ginecologia una donna di 60 anni, in menopausa da 5 anni, che riferisce perdite ematiche vaginali da qualche giorno. La donna riferisce al medico di avere recentemente eseguito un Pap test con esito regolare e di non aver avuto traumi genitali o rapporti sessuali negli ultimi giorni. La strategia diagnostica iniziale più adeguata tra le seguenti è:

- A: Ecografia pelvica transvaginale seguita da isteroscopia
- B: Tampone microbiologico vaginale
- C: HPV-DNA test
- D: Colposcopia
- E: Vulvoscopia

CC: Abbiamo una donna di 60 anni in menopausa, sanguinamenti in questa fascia di età possono essere attribuiti a polipi o a carcinoma endometriale. per questo la prima scelta è un'ecografia seguita poi da isteroscopia con biopsia.

Difficoltà: Media

Domanda 28: (codice domanda: ssm2023468)

Una gestante alla trentaquattresima settimana di gravidanza si reca in Pronto Soccorso per forti algie pelviche, intensa cefalea e dolore a barra. Il quadro clinico evidenzia PA = 150/100, contrazioni uterine tetaniche, perdite ematiche genitali, dilatazione della cervice 2 cm, alterazioni del tracciato cardiocografico con bradicardia e decelerazioni tardive. La diagnosi più probabile è:

- A: Distacco di placenta
- B: Minaccia di parto pretermine
- C: Parto pretermine con rottura delle membrane



- D: Placenta previa
- E: Prolasso del funicolo

CC: In questo caso la paziente presenta sanguinamento vaginale, contrazione uterine massive e sofferenza alla cardiotocografia, una triade tipica di un distacco di placenta.

Difficoltà: Media

Domanda 29: (codice domanda: ssm2023469)

Una ragazza di 15 anni si presenta con la mamma in visita dal ginecologo perché non è ancora comparso il menarca. La ragazza, nata da parto eutocico, dimostra uno sviluppo completo dei caratteri sessuali secondari e un'altezza nella norma per età ed etnia; la paziente riferisce però saltuarie algie addominali circa una volta al mese, che si risolvono dopo qualche giorno e l'assunzione di antidolorifici. Quale tra le seguenti diagnosi è la più probabile?

- A: Imene imperforato
- B: Rabbdomiosarcoma vaginale
- C: Leiomioma sottosieroso uterino
- D: Endometriosi
- E: Sindrome di Rokitansky

CC: Ci troviamo di fronte ad una ragazza di 15 anni, quindi dobbiamo concentrarci sulle patologie che possono colpire questa fascia di età. la paziente ci riferisce dolori sporadici circa una volta al mese, verosimilmente attribuibili al ciclo mestruale, possiamo escludere inoltre l'endometriosi in quanto la paziente avrebbe dolore pelvico cronico. La sindrome di Rokitansky è una malattia rara, caratterizzata dall'assenza congenita della vagina e dell'utero, ma il testo ci dice come abbia uno sviluppo normale la nostra paziente

Difficoltà: Media

Domanda 30: (codice domanda: ssm2023470)

Quale dei seguenti farmaci è assolutamente controindicato in gravidanza?

- A: Methotrexate
- B: Paracetamolo
- C: Insulina
- D: Eparina
- E: Nifedipina



CC: Il Metotrexate è un farmaco che interferisce con la crescita di alcune cellule, soprattutto quelle che si moltiplicano velocemente, come le cellule tumorali, viene utilizzato soprattutto nella GEU, ecco spiegato quindi perchè non può essere somministrato in gravidanza.

Difficoltà: Facile

Domanda 31: (codice domanda: ssm2023471)

Quale tra le seguenti modificazioni del funzionamento dell'apparato cardiovascolare NON fa parte dell'adattamento materno fisiologico alla gravidanza?

- A: Riduzione della gittata cardiaca
- B: Aumento del volume cardiaco
- C: Modificazione della posizione del cuore per elevazione del diaframma
- D: Aumento della frequenza cardiaca
- E: Riduzione della pressione arteriosa

CC: La gravidanza comporta in tutti gli organi e i sistemi materni una serie di modificazioni fisiologiche. La gittata cardiaca aumenta dal 30 al 50% a partire dalla 6a settimana di gestazione e raggiunge il suo massimo tra la 16a e la 28a settimana (di solito intorno alla 24a settimana). Il volume totale di sangue aumenta proporzionalmente alla gittata cardiaca, ma l'aumento del volume plasmatico è maggiore. Le modificazioni della funzione renale vanno quasi di pari passo con quelle della funzione cardiaca. La velocità di filtrazione glomerulare aumenta dal 30 al 50%. La pressione arteriosa tende ad essere più bassa per effetto del progesterone.

Difficoltà: Media.

Domanda 32: (codice domanda: ssm2023472)

Quale dei seguenti reperti clinico-strumentali NON è tipico della mola vescicolare completa?

- A: Beta-hCG ridotta per l'epoca gestazionale
- B: Metrorragia
- C: Ipertensione
- D: Presenza di cisti ovariche multiple
- E: Assenza di embrione e/o feto all'ecografia

CC: La mola vescicolare completa è una malattia del trofoblasto che impedisce la normale crescita dell'embrione. essa si caratterizza per: Beta-hCG elevata per l'epoca gestazionale, utero voluminoso, sanguinamento, pre-eclampsia, cisti ovariche teco-luteiniche ed aspetto a tempesta di neve all'ecografia.

Difficoltà: Difficile



Domanda 33: (codice domanda: ssm2023473)

Quale tra le seguenti è una frequente complicazione delle fratture della parete posteriore dell'acetabolo con lussazione della testa femorale?

- A: Paralisi del nervo sciatico
- B: Lesione dell'arteria iliaca esterna
- C: Paralisi del nervo femorale
- D: Rottura dell'arteria femorale profonda
- E: Paralisi del nervo otturatorio

CC: Domanda incentrata sulla conoscenza della posizione delle strutture anatomiche. Considerando quindi che stiamo parlando di parete posteriore andremo ad escludere tutte le strutture localizzate anteriormente rispetto all'articolazione dell'anca (nervo femorale e arteria femorale profonda), ma anche l'arteria iliaca esterna, essendo questa localizzata prima del passaggio dalla lacuna dei vasi (mediale rispetto alla lacuna dei muscoli); escluderemo inoltre la risposta E facendo mente locale sul decorso del nervo otturatorio insieme ai vasi otturatori lungo la parete laterale della cavità pelvica, fino al canale otturatorio, per poi raggiungere la loggia mediale della coscia. Quindi non rimane che il nervo sciatico che, in termini anatomici, si localizza esattamente posteriormente alla parete acetabolare, dopo la sua uscita dalla pelvi attraverso il grande foro ischiatico

Difficoltà: Facile

Domanda 34: (codice domanda: ssm2023474)

Una donna di 53 anni, che espleta il lavoro di segretaria, riferisce al proprio medico curante disturbi alla mano destra iniziati da alcuni mesi. Nello specifico lamenta dolore e parestesie in corrispondenza delle prime tre dita della mano che peggiorano durante la notte. Il dolore e le parestesie peggiorano nella iperflessione del polso ed il segno di Tinel è positivo. Ispettivamente si apprezza ipotrofia dell'eminanza tenar dal lato interessato. Qual è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- A: Sindrome del tunnel carpale
- B: Sindrome del tunnel cubitale
- C: Una compressione del nervo ulnare al livello del canale di Guyon
- D: Esiti post-traumatici
- E: Sindrome di Pancoast

CC: Considerando la sintomatologia localizzata a livello della mano andremo ad escludere le risposte che fanno riferimento ad altri territori anatomici (sindrome di Pancoast e sindrome del tunnel cubitale). Andando a vedere poi la sintomatologia è necessario qui fare riferimento a conoscenze relative all'innervazione della mano: le



prime tre dita della mano vengono innervate dal nervo mediano (superficie palmare + superficie volare dell'estremità distale delle prime tre dita) che si preoccupa anche dell'innervazione dei muscoli dell'eminanza tenar. Avendo questo nervo decorso all'interno del tunnel carpale, considereremo la risposta A. La presenza poi di positività al segno di Tinel (test per la valutazione della sindrome del tunnel carpale), dolore all'iperflessione e il peggioramento notturno sono ulteriori indicazioni a supporto della risposta A.

Difficoltà: Facile

Domanda 35: (codice domanda: ssm2023475)

Un ragazzo di undici anni frequenta una scuola di calcetto. Gli allenamenti si svolgono da alcuni mesi su un campo in cemento. Il ragazzo lamenta da quattro settimane dolore al tallone che migliora a riposo e peggiora dopo gli allenamenti. All'esame obiettivo si apprezza dolore alla pressione in corrispondenza della porzione posteriore del calcagno. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Malattia di Sever
- B: Malattia di Köhler
- C: Malattia di Freiberg
- D: Malattia di Panner
- E: Malattia di Sinding-Larsen-Johansson

CC: Si tratta di una domanda basata sulla pura conoscenza dei nomi delle sindromi citate. La malattia di Sever corrisponde all'epifisite del calcagno dovuta ad una rottura tra l'apofisi calcaneare e il corpo del calcagno che si verifica in pazienti di età pediatrica, prima che l'ossificazione del calcagno sia completa (entro i 15 anni di età), a seguito di intense sollecitazioni del tendine d'Achille sull'apofisi del calcagno. La diagnosi di questa malattia è puramente clinica: il dolore compare in pazienti in genere di 9-14aa di età, con anamnesi positiva per attività sportiva, specialmente quelli che indossano calzature senza tacco (es. scarpette da calcio); il dolore si aggrava alla stazione eretta sulle punte o durante la corsa.

Difficoltà: Difficile

Domanda 36: (codice domanda: ssm2023476)

Quale delle seguenti è la più frequente lesione neoplastica dello scheletro?

- A: Metastasi ossea
- B: Condrosarcoma
- C: Osteosarcoma



D: Cordoma

E: Osteoblastoma

CC: Domanda teorica: le lesioni neoplastiche più frequenti a livello osseo sono le Metastasi secondarie di altri tumori (mammella, polmone, prostata, tiroide, colon, melanoma, ecc).

Difficoltà: Facile

Domanda 37: (codice domanda: ssm2023477)

Un paziente di 65 anni viene sottoposto ad intervento di artroprotesi del ginocchio destro per presenza di una grave artrosi sintomatica. A distanza di due anni dall'intervento, durante i quali la sintomatologia dolorosa è completamente regredita, il paziente inizia a lamentare rigidità, dolore e tumefazione del ginocchio operato. Esegue un'artrocentesi del ginocchio che da esito ad un liquido torbido di colorito giallastro, concentrazione proteica di 3,7 g/dL, glucosio 10 mg/dL, LDH 4.800 U/L. L'ipotesi diagnostica più verosimile tra le seguenti è:

A: Infezione periprotetica

B: Errato posizionamento delle componenti protesiche

C: Sinovite villonodulare pigmentosa

D: Frattura periprotetica

E: Emartro

CC: Per poter rispondere a questa domanda è sufficiente avere bene a mente le caratteristiche del liquido sinoviale: in condizioni normali questo dovrebbe essere di colore giallo chiaro, di aspetto trasparente, a viscosità conservata e in assenza di alterazioni della composizione chimica. Il colore del liquido sinoviale nel caso presentato già permette di escludere la presenza di un emartro e l'eventuale frattura periprotetica. Considerando poi la composizione chimica che normalmente vedrebbe un livello di glucosio di poco inferiore a quelli ematico, possiamo orientarci verso il sospetto di infezione periprotetica, avendo in questo caso un livello di glucosio ridotto (la presenza di infezione infatti porta ad un consumo del glucosio da parte degli agenti infettivi) e un aumento delle LDH. La presenza poi di un valore $>3\text{g/dL}$ di proteine presuppone che si tratti di un essudato, caratteristica tipica delle forme infettive ($<3\text{g/dL}$ = trasudato).

Difficoltà: Media

Domanda 38: (codice domanda: ssm2023478)

In un paziente a cui in esito ad una TURV è stata diagnosticata una neoplasia vescicale pT1 G3, associata a Cis, dopo quanto tempo è necessario ripetere la TURV?



- A: Da 2 a 6 settimane
- B: Dopo 3 mesi
- C: Dopo 1 settimana
- D: Dopo 8 settimane
- E: Mai, si procede con la cistectomia radicale

CC: Domanda molto complessa e specifica. La TURV (resezione transuretrale della vescica) è una procedura chirurgica utilizzata per rimuovere un tumore vescicale non muscolo-invasivo. Nel caso di una neoplasia vescicale pT1 G3 associata a carcinoma in situ (Cis), che è un tumore ad alto grado di malignità, la ripetizione della TURV viene solitamente raccomandata per confermare la completezza dell'asportazione del tumore e per valutare l'estensione dell'invasione. Inoltre, la TURV ripetuta può essere utile per ottenere campioni di tessuto aggiuntivi per l'esame istologico e per determinare la necessità di ulteriori trattamenti, come la chemioterapia intravesicale. La tempistica specifica per la ripetizione della TURV può variare in base alle linee guida cliniche e alle decisioni del medico curante, ma di solito cade nell'intervallo di 2-6 settimane, intervallo che consente al paziente di guarire dalla procedura iniziale e di consentire al tessuto vescicale di rigenerarsi in modo ottimale per una valutazione accurata (fonte: Linee Guida EAU sul tumore vescicale non muscolo-invasivo).

Difficoltà: Difficile

Domanda 39: (codice domanda: ssm2023479)

Un uomo di 70 anni giunge all'osservazione dell'Urologo per un valore di PSA totale di 20,6 ng/mL. All'esame obiettivo l'esplorazione rettale è dubbia per neoplasia prostatica. L'iter diagnostico considerato attualmente più appropriato tra i seguenti è:

- A: RM multiparametrica della prostata, biopsia prostatica, scintigrafia ossea
- B: PET/TC con 18F-FDG
- C: Ecografia sovrapubica, biopsia prostatica
- D: Ecografia prostatica transrettale, TC addome pelvi
- E: Biopsia prostatica, TC addome pelvi senza MdC

CC: Con un sospetto così forte di neoplasia prostatica (altissimo valore del PSA ed esplorazione rettale quantomeno dubbia per neoplasia prostatica), l'unico esame in grado di dirci se ci sia o meno la presenza di neoplasia è la biopsia prostatica (risposta B e D errate). L'ecografia sovrapubica, per quanto possa andare ad indagare anche la prostata, non raggiunge la stessa Sn e Sp della RM multiparametrica (risposta C errata ed E errate), che risulta essere la risposta corretta. La TC addome-pelvi senza mdc non si usa per studiare la prostata, casomai ci vorrebbe 1. il contrasto e 2. nella pratica clinica si utilizza la total-body con mdc per una stadiazione post-diagnosi (dopo aver



fatto una scintigrafia ossea per indagare la presenza di eventuali metastasi ossee ed una PET/TC per la ricerca di malattia a distanza).

Difficoltà: Media.

Domanda 40: (codice domanda: ssm2023480)

Un paziente di 65 anni, operato da 3 mesi di prostatectomia radicale per una neoplasia con un Gleason 3+3, riferisce incontinenza diurna e notturna. La diagnosi più probabile tra le seguenti è:

- A: Incompetenza sfinteriale post-operatoria
- B: Iperattività detrusoriale idiopatica
- C: Stenosi uretrale
- D: Ridotta compliance detrusoriale
- E: Ostruzione cervico-uretrale

CC: Per prostatectomia radicale si intende l'asportazione chirurgica (retro pubica, perineale, trans coccigea, laparoscopica o robot-assistita) della prostata, delle vescicole seminali e la successiva anastomosi tra uretra e vescica. dopo l'intervento è frequente un periodo di incontinenza urinaria. Tale fenomeno si risolve nel 95-96% dei pazienti.

Difficoltà: Media

Domanda 41: (codice domanda: ssm2023481)

Un bambino di tre anni viene portato in Pronto Soccorso perché ha ingerito un numero imprecisato di compresse di acido acetilsalicilico. All'ingresso il bambino accusa vertigini soggettive, ha vomito, e all'obiettività si evidenzia tachipnea. Quale dei seguenti provvedimenti NON è corretto?

- A: Infondere rapidamente abbondanti liquidi per forzare la diuresi
- B: Eseguire radiografia del torace
- C: Somministrare carbone attivo
- D: Se necessario alcalinizzare le urine
- E: Valutare la stabilità del respiro e del circolo, posizionare accesso venoso, eseguire esami ematici (valutazione della salicilatemìa, emogasanalisi, glicemia, elettrolitemia, creatininemia, esame urine)

CC: Domanda complessa sull'intossicazione da salicilati condizione caratterizzata da tachipnea, alcalosi respiratoria, acidosi metabolica, insufficienza multiorgano. Come in tutti i casi di sospetta Intossicazione grave bisogna stabilizzare innanzitutto il paziente e



poi dosare la concentrazione plasmatica della sostanza in esame. Dati gli effetti della sostanza sull'organizzazione saranno indicati anche esami ematici appropriati (risposta E errata). Sarà poi necessario favorire un minor assorbimento del farmaco col carbone vegetale attivo (risposta C errata) e favorire la sua eliminazione dall'organismo tramite alcalinizzazione delle urine, che aumenta l'eliminazione urinaria dell'acido salicilico (risposta D errata). Una delle possibili complicanze dell'intossicazione da salicilati è l'edema polmonare motivo per cui è indicato effettuare una RX del torace alla diagnosi (risposta B errata) mentre è controindicato un sovraccarico eccessivo di fluidi (risposta A corretta).

Difficoltà: Difficile

Domanda 42: (codice domanda: ssm2023482)

Una bambina di due anni viene portata in Pronto Soccorso per un quadro insorto rapidamente da un'ora circa, caratterizzato da tosse abbaiente, stridore inspiratorio, agitazione, febbre elevata, scialorrea, disfagia. SpO₂ in aria ambiente uguale 90%. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Epiglottite acuta
- B: Laringite ipoglottica
- C: Inalazione di corpo estraneo
- D: Bronchiolite
- E: Polmonite

CC: Il quadro, caratterizzato da febbre, dispnea con distress respiratorio, disfagia con scialorrea deve subito far pensare ad epiglottite acuta. La laringite si presenta con StridoR, Raucedine e tosse laringea abbainate (baRking cough) ma raramente presenta tale gravità, la febbre inoltre non è mai così elevata e non è presente disfagia con scialorrea. L'inalazione da corpo estraneo può determinare dispnea disfagia con scialorrea e disfonia ma la febbre non è presente. Bronchilite e polmonite possono causare distress respiratorio ma non sono presenti sintomi a carico delle "alte vie respiratorie" quali disfagia, disfonia e tosse abbaiente.

Difficoltà: Media

Domanda 43: (codice domanda: ssm2023483)

Viene ricoverato un bambino di cinque anni che presenta un rash cutaneo purpureo palpabile localizzato in particolare agli arti inferiori, dolori addominali associati a tracce ematiche nelle feci, dolore articolare, tumefazione alle ginocchia ed ematuria macroscopica. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?



- A: Porpora di Schonlein-Henoch
- B: Malattia reumatica
- C: Artrite idiopatica giovanile
- D: Malattia di Kawasaki
- E: Orticaria da farmaci

CC: Quadro classico di Porpora di Schonlein-Henoch, vasculite dei piccoli vasi dovuta a deposito di immunocomplessi ad IgA e coinvolgimento di cute con porpora palpabile nelle sedi declivi, articolazioni, reni e apparato gastrointestinale. La sola porpora palpabile basta per porre clinicamente la diagnosi.

Difficoltà: Facile

Domanda 44: (codice domanda: ssm2023484)

Una ragazza di 12 anni presenta da alcuni giorni un quadro clinico in progressivo peggioramento, caratterizzato da labilità emotiva e continui brevi ed involontari movimenti degli arti e della mimica facciale, non presenti durante il sonno. La ragazza due mesi fa circa ha sofferto di una tonsillite febbrile, accompagnata da malessere e tumefazione dolente dei linfonodi sottomandibolari e seguita da dolore e tumefazione migranti alle articolazioni delle ginocchia. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Corea di Sydenham
- B: Insorgenza di un quadro psicotico
- C: Crisi epilettiche parziali
- D: Crisi d'ansia
- E: Dermatomirosite

CC: La comparsa di disturbi ipercinetici del movimento (corea) in un bambino con pregressa tonsillite febbrile (da SBEGA, come è molto probabile nel caso presentato data l'età la presentazione clinica) deve far sospettare una Corea di Sydenham, quadro transitorio a buona prognosi, la quale può presentarsi in modo isolato o preceduta o accompagnata da altre manifestazioni della malattia reumatica (manifestazioni dermatologiche, cardite, artralgie/artrite).

Difficoltà: Media

Domanda 45: (codice domanda: ssm2023485)

Un bambino di cinque anni con storia di trauma cranico accidentale occorso cadendo da circa un metro d'altezza, arriva in Pronto Soccorso. All'ingresso il bambino è vigile, orientato ed ha un esame obiettivo generale e neurologico negativo e ricorda e descrive



l'accaduto. Lamenta soltanto una cefalea di media entità. Il bambino dopo il trauma ha pianto subito ed ha vomitato. Quale tra i seguenti comportamenti clinici è il più indicato?

- A: Rassicurare i genitori e trattenere il bambino per un periodo di osservazione clinica in Pronto Soccorso
- B: Ricoverare il bambino per le prime 96 ore dopo trauma
- C: Eseguire radiografia del cranio per valutare la presenza di eventuali fratture
- D: Eseguire TC del cranio urgente
- E: Rassicurare i genitori e dimettere il bambino, dando indicazioni per un eventuale nuovo accesso in Pronto Soccorso

CC: Nel caso di trauma cranico non commotivo (senza perdita di coscienza: il bambino piange subito) senza red flags dovuti alla dinamica del trauma (caduta da altezza maggiore dell'altezza del bambino, trauma ad alta energia, presenza di fratture del cranio, politrauma, ecc) o alla presenza di sintomi neurologici focali o da ipertensione e endocranica non è indicato in prima linea l'esecuzione di un imaging cerebrale. Bisognerà invece tenere in osservazione il bambino (prima in pronto soccorso e poi a domicilio) e rassicurare i genitori. Una lieve cefalea e la presenza di pochi episodi di vomito isolati con un restante quadro neurologico normale non sono per forza suggestivi di ipertensione endocranica e possono essere presenti dopo il trauma.

Difficoltà: Media

Domanda 46: (codice domanda: ssm2023486)

Un lattante di dieci mesi di origini nigeriane, in Italia da poche settimane, giunge in Pronto Soccorso per pianto inconsolabile. Non presenta febbre. Alla valutazione clinica si osservano irritabilità, tachicardia ed edema di tre dita della mano destra, che appaiono calde ed eritematose. La restante obiettività clinica è nella norma, ad eccezione di modica epatosplenomegalia. Qual è l'ipotesi diagnostica più probabile?

- A: Drepanocitosi
- B: Artrite psoriasica
- C: Patereccio erpetico
- D: Leucemia acuta
- E: Congelamento

CC: Domanda di difficile interpretazione che richiede di porre una diagnosi sulla base di un quadro clinico aspecifico. Ragionando per esclusione, il Congelamento non è un'opzione in assenza di richiamo anamnestico nella domanda. L'artrite psoriasica può presentarsi con dattilite ma non è comune in un lattante. Una leucemia acuta si può presentare nei modi più diversi a tutte le età ma non è sicuramente l'opzione più



probabile in assenza di informazioni sull'emocromo o la morfologia delle cellule allo striscio di sangue periferico. Il pateruccio erpetico potrebbe presentarsi con edema ed eritema di uno o più dita associato a crisi dolorose, ma sarebbero presenti le caratteristiche vescicole, inoltre non spiegherebbe la tachicardia o l'epatosplenomegalia. Il quadro clinico qui presentato di un lattante proveniente dall'Africa subsahariana che si presenta acutamente con segni di anemizzazione (tachicardia), epatosplenomegalia, crisi dolorose (il dolore in un lattante di sei mesi può determinare pianto inconsolabile e irritabilità) e sintomi vaso occlusione a carico delle estremità (dita calde ed eritematose) deve far pensare ad esordio di drepanocitosi. La malattia si manifesta SEMPRE mesi dopo la nascita, dopo che i livelli di Hb fetale si sono ridotti. Le crisi dolorose vaso occlusive, come in questo caso, sono la manifestazione clinica più frequente.

Difficoltà: Difficile

Domanda 47: (codice domanda: ssm2023487)

Arriva in Pronto Soccorso un lattante di tre mesi con tosse e "wheezing", che presenta all'obiettività rientramenti intercostali, alitamento delle pinne nasali, bilancia toraco-addominale ed aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Non è febbrile, ma viene riferita scarsa assunzione di latte da alcune ore. Nel sospetto di bronchiolite quale comportamento clinico tra i seguenti è più corretto assumere in questo caso?

- A: Somministrare ossigeno se la SpO₂ in aria ambiente è inferiore al 94%, posizionare un accesso venoso e disporre il ricovero
- B: Somministrare O₂ e cortisonici per aerosol e provare ad alimentarlo
- C: Somministrare O₂ e cortisonici per aerosol e richiedere RX del torace
- D: Somministrare aerosol con soluzione salina ipertonica e adrenalina, iniziare terapia antibiotica e predisporre il ricovero
- E: Provare ad alimentare il lattante, consolandolo in attesa della radiografia del torace

CC: Ci viene chiesto quale sia l'approccio corretto di fronte ad un caso classico di bronchiolite, patologia respiratoria ad eziologia virale e principale causa di ospedalizzazione nei lattanti sotto l'anno di età. Le nuove linee guida nazionali e internazionali ribadiscono come il trattamento sia basato esclusivamente su misure di supporto quali lavaggi nasali, misure posturali dopo l'alimentazione, idratazione. Nei casi più gravi con disidratazione importante potrebbe essere necessario effettuare fluidoterapia endovenosa. Di fronte a casi in cui sia presente una ridotta SpO₂ è importante procedere con la somministrazione di Ossigenoterapia. Non sono invece indicate di default terapia aerosolica con broncodilatatore o adrenalina, terapia steroidea, terapia antibiotica né l'esecuzione di approfondimenti diagnostici



strumentali.

Difficoltà: Facile

Domanda 48: (codice domanda: ssm2023488)

Viene portata dal pediatra una bambina di quattro anni che lamenta da alcuni giorni artralgie migranti e mialgie. L'esame obiettivo è sostanzialmente negativo. La madre riferisce che una settimana prima dell'esordio della sintomatologia aveva notato nella bambina la presenza di un'area eritematosa, con zona centrale più pallida sulla superficie posteriore della gamba sinistra, a livello del cavo popliteo, durata parecchi giorni e risoltasi spontaneamente. La bambina era stata in vacanza in una zona collinare del Friuli-Venezia Giulia. Quale tra le seguenti ipotesi diagnostiche è la più probabile?

A: Malattia di Lyme

B: Distrofia muscolare di Duchenne

C: Malattia reumatica

D: Artrogriposi

E: Artrite idiopatica giovanile

CC: Il quadro clinico qui presentato è caratterizzato da mialgie e artralgie migranti (reattive) e pregressa presenza di lesione cutanea "a bersaglio" (intensamente eritematosa con area centrale più chiara). Tale lesione è patognomonica della malattia di Lyme, causata da *Borrelia burgdorferi*, batterio spiraliforme trasmesso da zecche. Altre possibili manifestazioni della patologia sono a carico del sistema nervoso centrale e periferico. Nella malattia reumatica possono essere presenti artralgie o artriti migranti, ma essa segue sempre una faringite streptococcica ed è spesso caratterizzata da un quadro febbrile. L'artrite idiopatica giovanile è caratterizzata da artrite persistente (di durata superiore a 6 settimane) associata o meno ad altre manifestazioni.

Difficoltà: Media

Domanda 49: (codice domanda: ssm2023489)

Una donna di 43 anni giunge alla nostra osservazione per la comparsa, da alcuni mesi, di episodi ricorrenti di dispnea per broncocostrizione. Concomitano congestione nasale ed artralgie. Alla radiografia del torace si evidenziano infiltrati polmonari multipli e periferici. Quale tra queste diagnosi deve essere presa primariamente in considerazione?

A: La granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA)



- B: Arterite di Takayasu
- C: Artrite reumatoide con interessamento polmonare
- D: Malattia di Behcet
- E: Dermatomiosite

CC: Gli elementi che ci consentono di giungere alla diagnosi di EGPA sono congestione nasale, artralgie e quadro polmonare alla RX caratterizzato da infiltrati multipli e periferici (addensamenti subpleurici). Infatti questa vasculite ha un tropismo mirato per le vie aeree superiori e i seni paranasali, determinando talora quadri destruenti. L'artrite reumatoide, che pure è caratterizzata da artralgie, determina invece un quadro polmonare di natura fibrotica (interstiziale). Le altre opzioni B, D ed E non sono caratterizzate in genere da un interessamento polmonare.

Difficoltà: Media

Domanda 50: (codice domanda: ssm2023490)

Giunge in ambulatorio un uomo di 32 anni con prurito diffuso senza interessamento del capo presente da due settimane. Riferisce che il prurito è più accentuato nelle ore notturne. Alla valutazione clinica sono presenti papule, alcune escoriate, e lesioni da grattamento. Alla faccia laterale del secondo dito di una mano si osservano lesioni lineari di circa un centimetro di lunghezza con una piccola papula ad una estremità. Quale tra le seguenti è la prima patologia che si deve sospettare?



- A: Scabbia
- B: Orticaria
- C: Leishmaniosi cutanea



D: Pemfigoide bolloso

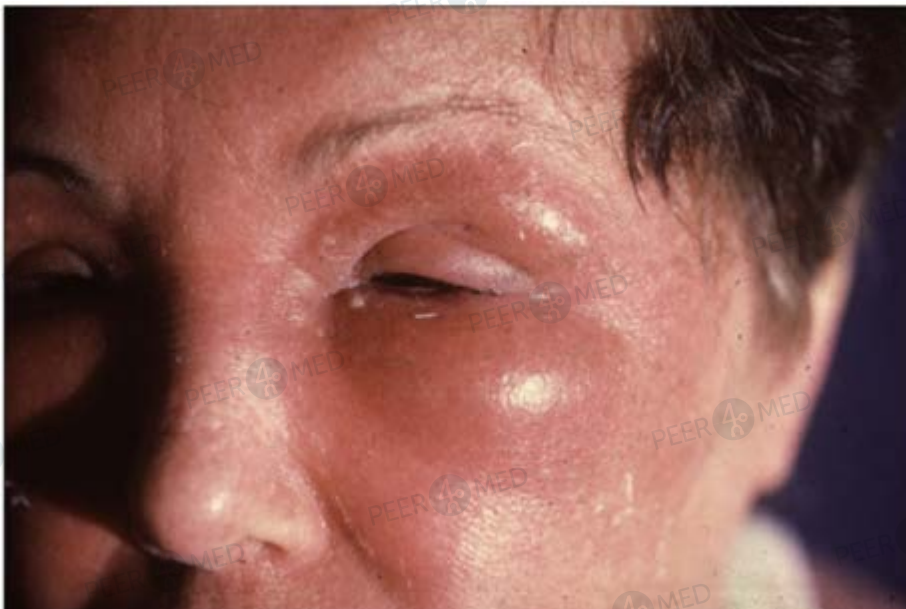
E: Pediculosi

CC: La domanda descrive alcuni aspetti molto caratteristici della scabbia: il prurito diffuso con esclusione del capo (solo nei bambini è interessato anche il cuoio capelluto) accentuato durante la notte. Le lesioni più frequentemente riscontrabili sono papule, noduli e lesioni da grattamento. Inoltre il testo della domanda descrive a parole i cunicoli (visibili anche dalla fotografia), ovvero le lesioni "patognomoniche" della scabbia. Non si sospetta l'orticaria perché non vi è menzione di pomfi, né il pemfigoide poiché si è in assenza di bolle; inoltre non vi è anamnesi di puntura di insetto e non vi è un'ulcera, quindi anche la Leishmania si può escludere. Per quanto riguarda la pediculosi, non viene segnalata la presenza di lendini e il prurito della pediculosi non è accentuato durante le ore notturne.

Difficoltà: Facile

Domanda 51: (codice domanda: ssm2023491)

Giunge al reparto di dermatologia una paziente di 60 anni con eruzione maculo-papulosa morbilliforme diffusa, edema del volto, intenso prurito e febbre elevata. Tre settimane prima aveva iniziato un trattamento con allopurinolo. Si eseguono esami ematici con riscontro di ipereosinofilia (2000/mm³), linfociti atipici (più del 5%), aumento di transaminasi, lipasi e amilasi. Il quadro clinico è compatibile con:



A: Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)

B: Dermatite livedoide di Nicolau



C: Acute Generalized Esantematic Pustolosis (AGEP)

D: Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexural Exanthema (SDRIFE)

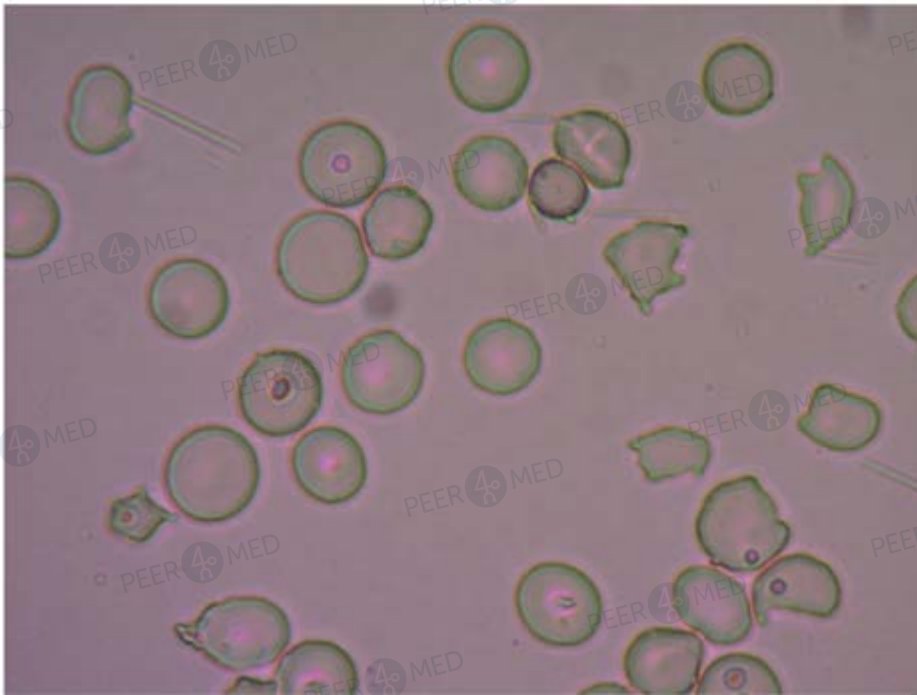
E: Sindrome di Sezary

CC: Il testo della domanda indirizza verso una grave reazione avversa a farmaco, causata dalla precedente assunzione di allopurinolo. La DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) è la risposta corretta perché è caratterizzata da un esantema maculo-papuloso morbilliforme e in gran parte dei casi da un marcato edema del volto (come in figura). Vi è inoltre una marcata sintomatologia sistemica, come febbre, linfadenopatie e coinvolgimento degli organi interni come fegato, rene, pancreas ecc.. Inoltre agli esami di laboratorio è caratteristica l'ipereosinofilia, sindrome mononucleosica con linfociti atipici e aumento di LDH. La dermatite livedoide di Nicolau si presenta invece in seguito all'iniezione per errore di un farmaco in arteria o per vasospasmo: si presenta un'immediata vasocostrizione con comparsa di pallore cutaneo e dolore; poi si crea un'area, a volte importante, di necrosi che può arrivare anche a tutto l'arto con danno neurologico, ortopedico e necrosi muscolare. La SDRIFE (Symmetrical Drug-Related intertriginous and Flexural Exanthema) è una reazione cutanea ritardata non severa localizzata sui glutei, sull'inguine e sul solco intergluteo, caratterizzata da un esantema maculopapuloso a margini netti. La AGEP (Acute Generalized Esantematic Pustolosis) inizialmente si presenta invece come un esantema, su cui compaiono micro-pustole sterili non follicolari pruriginose con tendenza alla confluenza, soprattutto a livello di tronco, estremità, volto e pieghe cutanee. La Sindrome di Sezary è una forma aggressiva del linfoma cutaneo a cellule T, caratterizzata dalla triade eritrodermia, linfadenopatia e linfociti atipici circolanti (cellule di Sézary).

Difficoltà: Facile

Domanda 52: (codice domanda: ssm2023492)

Allo striscio di sangue periferico si osserva questa morfologia eritrocitaria con schistociti. Il quadro è indicativo di:



- A: Microangiopatia trombotica
- B: Anemia emolitica autoimmune
- C: Ellissocitosi
- D: Macro-ovalocitosi
- E: Drepanocitosi

CC: La domanda chiede di interpretare un quadro "classico" riscontrabile allo striscio di sangue periferico. La presenza di schistociti (globuli rossi deformati o "decapitati") è suggestiva di Microangiopatia Trombotica. In questo gruppo di patologie la formazione di trombi nel microcircolo determina il consumo di piastrine (piastrinopenia) e la presenza di anemia emolitica con riscontro allo striscio di sangue periferico di schistociti. Da ricordare la differenza dei drepanociti o cellule a falce, tipici della drepanocitosi o anemia a cellule falciformi, in cui una mutazione della catena beta dell'emoglobina determina una deformazione dei globuli rossi.

Difficoltà: Facile

Domanda 53: (codice domanda: ssm2023493)

Un uomo di 78 anni con nota diverticolosi del colon e anamnesi ematologica negativa si presenta alla visita medica con anemia (Hb 6,8 g/dL, MCV 72 fL). Il numero delle piastrine, dei globuli bianchi e la formula leucocitaria sono normali. Questo quadro fa pensare, in prima istanza, a:



- A: Un'anemia da carenza di ferro
- B: Un'anemia da carenza di acido folico
- C: Una sindrome talassemica
- D: Un'anemia da carenza di vitamina B12
- E: Una porpora trombotica trombocitopenica

CC: Nella diagnosi differenziale delle anemie conviene sempre partire dal valore di MCV (volume corpuscolare medio; valore normale 72-86) che ci consente di suddividere le anemie in microcitiche e normo-macrocitiche. Il quadro di fronte al quale ci troviamo nel quesito è quello di un'anemia microcitica. I due principali quadri di anemia microcitica sono l'anemia sideropenica e la talassemia. Nel quesito l'età del paziente, l'anamnesi negativa per pregresse condizioni ematologiche e la presenza di una patologia del tratto gastrointestinale fanno pensare ad un'anemia acquisita da perdita di ferro piuttosto che ad una sindrome talassemica. La carenza di folati e di vitamina B12 determinano un'anemia macrocitica o addirittura megaloblastica. La porpora trombotica trombocitopenica è caratterizzata da anemia emolitica (normo-macrocitica con reticolociti aumentati, LDH e bilirubina indiretta aumentati e aptoglobina consumata) e piastrinopenia, di cui non si fa cenno del quesito.

Difficoltà: Facile

Domanda 54: (codice domanda: ssm2023494)

La tipizzazione linfocitaria di un paziente di 82 anni, che presenta una conta leucocitaria di 65.350 cellule/mm³, con linfociti rappresentanti l'82% dei leucociti, ha le seguenti caratteristiche: CD5+, CD23+, CD200+, CD20+dim, CD19+, slgk+dim, CD10-. Il quadro è diagnostico per:

- A: Leucemia linfatica cronica
- B: Linfocitosi monoclonale benigna
- C: Linfoma follicolare leucemizzato
- D: Leucemia plasmacellulare
- E: Leucemia acuta T-linfoblastica

CC: Ricordiamo nell'interpretazione dell'Immunofenotipo che la contemporanea espressione di CD5 e CD23 in una popolazione di derivazione B-cellulare (CD19+) è caratteristico della Leucemia Linfatica Cronica, malattia linfoproliferativa spesso indolente che colpisce la popolazione anziana e caratterizzata dalla presenza di linfocitosi su sangue periferico. Il quadro immunofenotipico e le informazioni fornite non sono sufficienti per porre diagnosi per le altre condizioni presentate tra le risposte.

Difficoltà: Media



Domanda 55: (codice domanda: ssm2023495)

Una paziente di 40 anni affetta da ipertensione arteriosa e con recente diagnosi di carcinoma papillare della tiroide è stata sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale e successiva terapia radiometabolica. Alla luce di tali informazioni l'andamento di quale fra i seguenti parametri è indicato seguire nel follow-up di questa paziente:

- A: Tireoglobulina
- B: CEA
- C: Calcitonina
- D: Cromogranina
- E: Anticorpi anti-recettore del TSH

CC: La tireoglobulina è un fondamentale marcatore tumorale per valutare l'efficacia della terapia del cancro della tiroide e per monitorare le recidive. Non tutti i tumori della tiroide producono tireoglobulina, ma i più comuni come il tumore papillare e quello follicolare della tiroide la sintetizzano determinandone un aumento delle concentrazioni ematiche. L'aumento di questa dopo l'asportazione è indice di una recidiva

Difficoltà: Media

Domanda 56: (codice domanda: ssm2023496)

La prolattina è un ormone polipeptidico prodotto e secreto dalle cellule lattotrope dell'adenipofisi. Fra le seguenti quale NON rappresenta una possibile causa di iperprolattinemia?

- A: Terapia con amiodarone
- B: Terapia con farmaci antagonisti dopaminergici
- C: Gravidanza
- D: Adenoma ipofisario secernente prolattina
- E: Craniofaringioma

CC: La prolattina è l'unico ormonale per il quale, in condizioni fisiologiche, predomina l'inibizione dovuta alla dopamina prodotta a livello ipotalamico, sulla stimolazione (su effetto del RH). La causa più frequente di iperprolattinemia è quella iatrogena: diversi farmaci possono provocarla, pertanto l'anamnesi farmacologica risulta fondamentale in caso di riscontro di iperprolattinemia; tra di essi abbiamo farmaci neurolettici (aloperidolo), antipertensivi (calcio-antagonisti, alfa-metildopa), antidepressivi triciclici, oppiacei, H2-antagonisti. Questi farmaci sono in grado di inibire il rilascio di dopamina (Risposta B errata). Tra questi farmaci non rientra l'amiodarone (Risposta A corretta). La seconda causa più frequente di iperprolattinemia è la gravidanza; durante la gravidanza



infatti l'aumento di estrogeni e della prolattina favorisce la differenziazione della ghiandola mammaria (Risposta C errata). Tra le altre cause fisiologiche di aumento della prolattina dobbiamo ricordare anche l'allattamento, lo stress e i rapporti sessuali. Tra le cause di iperprolattinemia ritroviamo anche patologie ipotalamiche; tra di esse abbiamo gli adenomi ipofisari prolattino-secrente (singolarmente o in associazione ad altri ormoni) (Risposta D errata) e i craniofaringiomi (Risposta E errata); questi ultimi, in caso di compressione a carico del peduncolo ipofisario, determinano un ridotto apporto di dopamina a livello ipofisario, con conseguente rialzo della prolattina.

Difficoltà: Facile

Domanda 57: (codice domanda: ssm2023497)

Un uomo di 55 anni giunge con stigmate cliniche di acromegalia. Quale indagine è più utile all'accertamento diagnostico?

- A: Dosaggio di insulin like growth factor-I (IGF-I)
- B: Dosaggio di insulin like growth factor-II (IGF-II)
- C: Dosaggio di ormone della crescita (GH) dopo test al TRH
- D: Dosaggio di ormone della crescita (GH) dopo test all'arginina
- E: RX diretta cranio

CC: Nei pazienti con sospetta acromegalia, deve essere misurata la concentrazione sierica di IGF-1; i livelli di IGF-1 sono in genere notevolmente elevati (da 3 a 10 volte) e, poiché i livelli di IGF-1 non fluttuano come i livelli di ormone della crescita (GH), sono il modo più semplice per valutare l'ipersecrezione di ormone della crescita (GH). I livelli di IGF-1, inoltre, possono essere usati per monitorare la risposta alla terapia.

Difficoltà: Media

Domanda 58: (codice domanda: ssm2023498)

Un uomo di 77 anni, con progressivo decadimento delle condizioni generali, all'obiettività neurologica presenta tremore a riposo, ipertonia, rigidità muscolare e micrografia. L'ipotesi diagnostica più probabile tra le seguenti è:

- A: Malattia di Parkinson
- B: Malattia di Alzheimer
- C: Malattia di Kreutzfeldt-Jakob
- D: Malattia di Pick
- E: Sclerosi Multipla

CC: Tremore, ipertono rigido, micrografia ci fanno propendere maggiormente per un disturbo extrapiramidale lentamente progressivo. Per tale motivo, escludiamo la E (poiché viene interessato prevalentemente il sistema piramidale) e la C (poiché il



decadimento nei prioni è veloce ed interessa contemporaneamente tutte le funzioni del sistema nervoso: cerebellare, piramidale, extrapiramidale, cognitivo). B e D sono due demenze: la prima è caratterizzata da un deficit mnemonico e di altre funzioni cognitive, mentre la seconda dà una sintomatologia comportamentale e verbale, sebbene in una certa percentuale dei casi è possibile riscontrare un parkinsonismo; dunque sono da escludere. Un esordio frequentemente extrapiramidale di tipo ipocinetico è tipico della malattia di Parkinson.

Difficoltà: Facile.

Domanda 59: (codice domanda: ssm2023499)

Per la prima valutazione dei disturbi cognitivi nell'anziano quale tra i seguenti è il test più appropriato?

- A: Il Mini Mental State Examination
- B: Instrumental Activity of Daily Living
- C: Test del Quoziente Intellettivo per adulti
- D: Geriatric Depression scale
- E: Activities of Daily Living

CC: Le risposte B ed E sono da escludere, poiché sono dei test utilizzati per comprendere quale sia il grado di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane (per intenderci, anche un tetraparetico ha una autonomia molto limitata, ma ciò non vuol dire che abbia un deficit cognitivo). La D è una scala utilizzata nella valutazione iniziale della deflessione dell'umore negli anziani, dunque anch'essa da escludere perché non valuta i domini cognitivi. Infine, il quoziente intellettivo negli adulti non valuta il dominio cognitivo totale dell'individuo, sebbene in alcuni casi possano andare di pari passo; ad ogni modo, poiché non vengono valutati i vari domini cognitivi (orientamento, fluency, dominio visuo-spaziale, funzioni esecutive, a differenza del Minimental), non può essere utilizzato per il declino cognitivo: anche la C viene esclusa.

Difficoltà: Facile.

Domanda 60: (codice domanda: ssm2023500)

Un uomo di 85 anni con febbre a 38°C e tosse da due giorni, sviluppa uno stato confusionale fluttuante durante l'arco della giornata, caratterizzato da agitazione psicomotoria e allucinazioni. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Delirium
- B: Esordio di demenza
- C: Coma diabetico
- D: Abuso di benzodiazepine



E: Abuso di neurolettici

CC: Le risposte C e D sono da escludere poiché, verosimilmente, riducono drasticamente lo stato di coscienza. La risposta B sarebbe stata abbastanza plausibile, ma il paziente presenta iperpiressia e tosse, dunque è probabile che ci sia una causa secondaria che abbia causato la confusione, le allucinazioni e l'agitazione psicomotoria, perciò è da escludere. L'abuso di neurolettico (risposta E) può provocare ipertermia ed agitazione psicomotoria, per cui anche questa sarebbe stata plausibile, ma in anamnesi non abbiamo alcun dato sulla terapia, e soprattutto il paziente ha sviluppato la sintomatologia neurologica acuta dopo aver prima sviluppato febbre e tosse; in caso di abuso da neurolettici, di solito, la sintomatologia si verifica insieme. È più verosimile, invece, che il paziente abbia sviluppato una polmonite e questa si sia manifestata anche come delirium, che è la risposta corretta.

Difficoltà: Media.

Domanda 61: (codice domanda: ssm2023501)

Un uomo di 45 anni, fumatore, con un'anamnesi positiva per ipercolesterolemia e diabete, si reca presso il Pronto Soccorso, lamentando da circa 48 ore episodi di intenso dolore retrosternale, a riposo, con irradiazione alla spalla sinistra della durata di cinque-dieci minuti. All'ECG, eseguito durante uno degli attacchi, si osserva un sotto-slivellamento del tratto ST di 1,5 mm in V2-V5. Le analisi di laboratorio non mostrano alterazioni degli enzimi cardiaci. Quali tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

A: Angina instabile

B: Angina stabile

C: Infarto miocardico acuto

D: Scompenso cardiaco

E: Cardiomiopatia tako tsubo

CC: In questo esercizio il testo ci indirizza molto. Ci troviamo davanti ad un paziente con fattori di rischio, infatti è fumatore con ipercolesterolemia e diabete, ha un dolore tipico che si presenta a riposo (per questo escludo l'angina stabile), non ci da info su eventi stressanti (per questo escludo la tako tsubo) ed infine gli enzimi cardiaci non sono mossi, quindi escludo anche l'infarto.

Difficoltà: Facile

Domanda 62: (codice domanda: ssm2023502)

Il farmaco di prima linea, in assenza di controindicazioni, in una paziente di 54 anni con



diagnosi di angina stabile riscontrata durante una visita presso l'ambulatorio di cardiologia è:

- A: Beta-bloccante
- B: Nitrato a lunga durata d'azione
- C: Digossina
- D: Ranolazina
- E: Ivabradina

CC: In un paziente con una storia di angina stabile il primo farmaco in cronico che andiamo a somministrare sono i beta-bloccanti per ridurre il consumo miocardico di O₂ sotto sforzo.

Difficoltà: Facile

Domanda 63: (codice domanda: ssm2023503)

Lo spostamento verso l'atrio sinistro in sistole dei lembi della valvola mitrale, senza ispessimento, è segno ecocardiografico suggestivo di quale lesione valvolare?

- A: Prolasso della valvola mitrale
- B: Endocardite reumatica
- C: Stenosi mitralica
- D: Insufficienza valvolare grave
- E: Endocardite infettiva

CC: La situazione ci definisce un quadro ecocardiografico tipico di un prolasso valvolare mitralico

Difficoltà: Facile

Domanda 64: (codice domanda: ssm2023504)

Ad un uomo di 50 anni è stata diagnosticata cardiomiopatia dilatativa idiopatica. È stata prescritta una terapia a base di ACE-inibitori e betabloccanti. In questo caso sarebbe necessario prescrivere anche una terapia a base di:

- A: Antialdosteronici e SGLT2 inibitori
- B: Digossina e calcioantagonisti
- C: Cortisonici e diuretici
- D: Calcioantagonisti e SGLT2 inibitori
- E: Antialdosteronici e calcioantagonisti

CC: Il paziente presenta un quadro di scompenso cardiaco dato da cardiomiopatia dilatativa. Il trattamento in questi pazienti prevede una terapia contenente



ACE-inibitori, betabloccanti, Antialdosteronici e SGLT2 inibitori e diuretici per ridurre la sintomatologia

Difficoltà: Media

Domanda 65: (codice domanda: ssm2023505)

Una donna di 77 anni viene valutata per un possibile impianto di pacemaker. Indicazione certa all'impianto di pacemaker in caso di blocco Atrio-Ventricolare (A-V) viene data:

- A: Dal blocco A-V di III grado o di II grado avanzato sintomatico
- B: Dal blocco A-V di II grado con QRS stretti
- C: Dal blocco A-V di II grado tipo 1 asintomatico
- D: Dal blocco A-V di I grado
- E: Dalle malattie neuromuscolari con blocco A-V di I grado

CC: Le indicazioni all'impianto di un PMK sono: bradicardia sintomatica, Bav 2 mobitz 2 e BAV 3, extrasistoli non controllate da farmaci, pausa maggiore di 3 secondi sintomatica o 6 secondi asintomatica o insufficienza cardiaca con rallentamento della conduzione ventricolare.

Difficoltà: Facile.

Domanda 66: (codice domanda: ssm2023506)

Una paziente di 45 anni senza precedenti cardiovascolari salvo la presenza di ipertensione arteriosa in terapia con ramipril a basso dosaggio, si reca in Pronto Soccorso per un dolore toracico anteriore che non si modifica con lo sforzo ma con gli atti del respiro. Viene dosata la troponina ad alta sensibilità che risulta elevata, mentre l'ECG mostra un quadro compatibile con ripolarizzazione precoce e una frequenza cardiaca di 70 bpm. Qual è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- A: Miopericardite acuta
- B: Insufficienza mitralica da rottura di muscolo papillare
- C: Sindrome di Wolff-Parkinson-White
- D: Ulcera peptica
- E: Reflusso gastroesofageo

CC: Il quadro clinico ci descrive un paziente con dolore che si modifica con gli atti del respiro, questo già di può indirizzare verso un quadro di miopericardite, abbiamo inoltre innalzamento degli enzimi di necrosi che ci confermano la diagnosi.

Difficoltà: Media.



Domanda 67: (codice domanda: ssm2023507)

Un uomo di 70 anni si reca in Pronto Soccorso per un quadro di scompenso cardiaco congestizio secondario ad una pericardite costrittiva con funzione cardiaca altrimenti conservata. Quale di queste opzioni terapeutiche rappresenta il trattamento più adeguato?

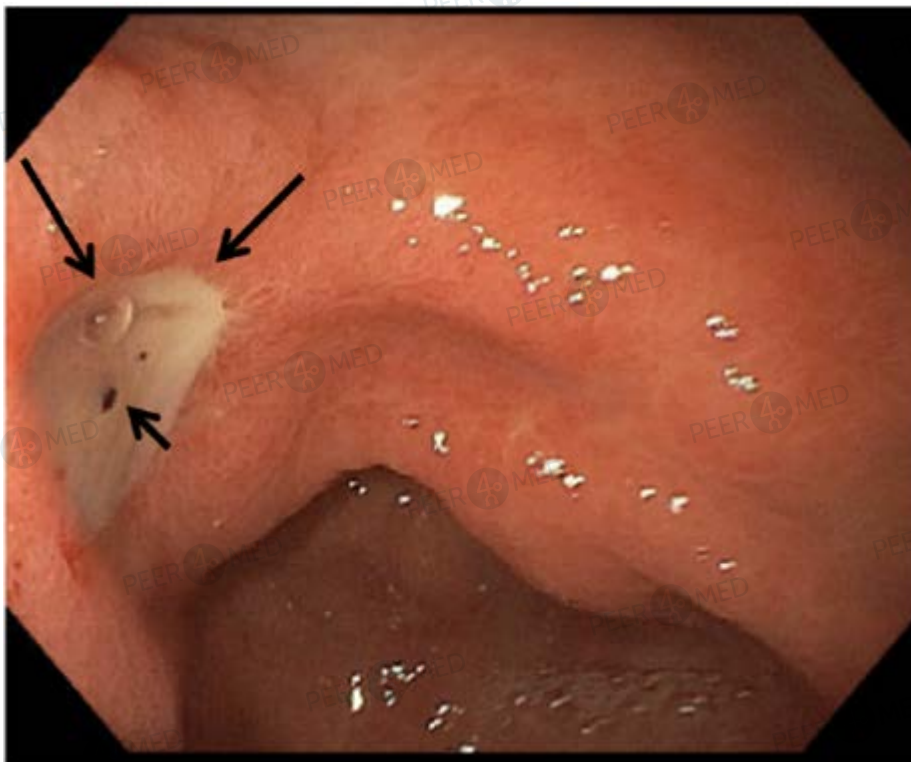
- A: Diuretici e chirurgia quando possibile
- B: Pericardiocentesi precoce
- C: Inotropi per via endovenosa
- D: Beta bloccanti e ACE inibitori
- E: FANS, cortisonici e pericardiocentesi in caso di mancata risposta

CC: In caso di pericardite con versamento pericardico la prima cosa da fare è dare diuretici al paziente e effettuare una chirurgia appena possibile. Escludiamo la Pericardiocentesi precoce che faremo invece in caso di tamponamento in quanto non sono presenti i sintomi tipici della triade di beck (ipotensione, turgore giugulare, toni parafonici).

Difficoltà: Facile.

Domanda 68: (codice domanda: ssm2023508)

Un paziente di 85 anni giunge all'ambulatorio di Endoscopia Digestiva per eseguire una esofagogastroduodenoscopia (EGDS) in seguito a riferita emissione di feci scure con riscontro agli esami ematochimici di anemia (Hb: 9.8 g/dL) ipocromica microcitica. L'EGDS mostra in sede antrale il quadro riportato. Qual è la diagnosi endoscopica di quanto osservato?



- A: Ulcera gastrica antrale tipo Forrest IIc
- B: Ulcera gastrica antrale tipo Forrest I
- C: Ulcera gastrica antrale tipo Forrest III
- D: Polipo iperplastico
- E: Singola formazione diverticolare dell'antro gastrico

CC: Il quadro clinico è tipico di un paziente con un'ulcera sanguinante, infatti il paziente ha anemia ipocromica microcitica. secondo la classificazione di Forrest abbiamo: Forrest I a (emorragia sgorgante), Forrest I b (emorragia stillante) Forrest II a (vaso visibile non sanguinante) Forrest II b (coagulo aderente) Forrest II c (ematina pigmentata piatta (base macinata di caffè) su base ulcera) Forrest III (Lesioni senza segni di emorragia recente o base dell'ulcera pulita ricoperta di fibrina)

Difficoltà: Media

Domanda 69: (codice domanda: ssm2023509)

Un paziente di 63 anni affetto da cirrosi epatica dismetabolica ed alcool relata è stato recentemente dimesso dal reparto di gastroenterologia dove era stato ricoverato per stato confusionale secondario ad encefalopatia epatica. Quale fra le terapie sottoelencate è più appropriata per la prevenzione della recidiva di encefalopatia epatica?



- A: Lattulosio/lattitolo + rifaximina
- B: Lattulosio/lattitolo + metronidazolo
- C: Lattulosio/lattitolo + propranololo
- D: Lattulosio/lattitolo + furosemide
- E: Lattulosio/lattitolo + canrenone

CC: Domanda che lascia poco spazio al ragionamento purtroppo. La prevenzione dell'encefalopatia epatica viene fatta con Lattulosio/lattitolo + rifaximina, un antibiotico utilizzato nel trattamento antimicrobico di infezioni intestinali sostenuti da batteri Gram + e Gram -.

Difficoltà: Media

Domanda 70: (codice domanda: ssm2023510)

Ad un paziente di 80 anni con storia di pregressa ulcera gastrica viene prescritto acido acetilsalicilico a basse dosi. Quale ulteriore farmaco è bene che venga prescritto?

- A: Inibitore di pompa protonica per os
- B: Misoprostolo a dose standard per os
- C: Misoprostolo ad alte dosi per os
- D: Dispositivo medico con idrossido di alluminio e acido ialuronico per os
- E: Sucralfato per os

CC: Gli IPP sono efficaci anche nella prevenzione secondaria delle ulcere gastriche e duodenali nei pazienti in trattamento cronico con FANS o aspirina per questo al paziente andremo a prescrivere proprio un IPP per os.

Difficoltà: Facile

Domanda 71: (codice domanda: ssm2023511)

In un paziente di 74 anni ricoverato in un reparto di Pneumologia per dispnea acuta non febbrile ed insufficienza respiratoria acuta ipossiémica di natura da definire, con RX torace che non mostra nessuna lesione a focolaio, quale tra i seguenti accertamenti diagnostici è irrinunciabile?

- A: Dosaggio D-dimero ematico
- B: Ricerca antigeni urinari *Legionella pneumophila* e *Streptococcus pneumoniae*
- C: Procalcitoninemia
- D: TC torace senza contrasto
- E: Mioglobulinemia



CC: Il caso clinico ci pone davanti ad un paziente dispnoico acuto NON febbrile con ipossiemia. Tale indizio ci permette subito di escludere condizioni di natura infettiva anche alla luce della RX che non evidenzia lesioni pleuroparenchimali a focolaio. Per tale motivo è possibile escludere l'opzione A che ci aiuterebbe nella diagnosi di una legionellosi polmonare e polmonite pneumococcica, l'opzione C, ove la procalcitonina è un markers infettivo principalmente di natura batterica e l'opzione D in quanto non ha senso procedere con una diagnostica di II livello senza contrasto quando quella di I livello è negativa. Non vi sono elementi anamnestici per pensare ad una causa cardiaca ed in ogni caso l'esame di primo livello da richiedere sarebbe la troponina (opzione E errata). Il paziente ha molto probabilmente una TEP, pertanto è utile richiedere il D-dimero che si inserisce nell'iter diagnostico di quest'ultima, associato ad una angio-TC torace che ne rappresenta l'elemento diagnostico gold-standard.

Difficoltà: Facile.

Domanda 72: (codice domanda: ssm2023512)

Una paziente di 73 anni, ex fumatrice di 70 pack-years, in ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per una BPCO (ultima spirometria eseguita circa 12 mesi prima con VEMS post-broncodilatatore pari al 30% del teorico) viene ricoverata per la presenza di insufficienza respiratoria cronica riacutizzata secondaria a polmonite acquisita in comunità al lobo medio e scompenso cardiaco. Quale tra i seguenti trattamenti è irrinunciabile?

- A: Ossigenoterapia
- B: Glucocorticoidi per via sistemica
- C: Nitroderivati per via endovenosa
- D: Beta-bloccante per via endovenosa
- E: Aminofillina per via endovenosa

CC: Sia per la condizione anamnestica di base (paziente con BPCO in O2tp domiciliare) che per il motivo del ricovero attuale (CAP) complicata da scompenso cardiaco è sicuramente irrinunciabile il supporto ossigenoterapico anche durante la degenza.

L'opzione B, C, D ed E non sono trattamenti da eseguirsi in corso di tali problematiche: in particolare i glucocorticoidi e l'aminofillina ev si somministrano in corso di gravi episodi asmatici e il beta-bloccante e nitroderivati in corso di acuzie di natura cardiaca.

Difficoltà: Facile

Domanda 73: (codice domanda: ssm2023513)

Una donna di 65 anni, ex fumatrice di 40 pack-years, affetta da BPCO con VEMS pari al 28% del teorico (ultima spirometria eseguita circa sei mesi fa) giunge all'osservazione



con la seguente emogasanalisi arteriosa eseguita mentre la paziente respirava aria ambiente: pH=7,35, PaO₂=40 mmHg, PaCO₂=55 mmHg, HCO₃⁻=27 mmol/L. Questa emogasanalisi è più indicativa di una paziente con:

- A: Insufficienza respiratoria acuta parziale con acidosi respiratoria compensata
- B: Insufficienza respiratoria globale acuta su cronica con acidosi respiratoria scompensata
- C: Acidosi metabolica pura
- D: Alcalosi respiratoria
- E: Alcalosi metabolica

CC: Domanda chiacchieratissima. Cerchiamo di comprendere il ragionamento sottostante. Anzitutto escludiamo con facilità le opzioni inerenti l'alcalosi (pH ai limiti inferiori della normalità, quindi non in range alcalotico). Rimanevano l'acidosi metabolica pura, che però cozza con la quota di bicarbonati in range (semmai un pochino più alti del limite 24) e quindi escludibile. Le opzioni inerenti l'insufficienza respiratoria potevano essere scriminate osservando che l'acidosi in questo caso è compensata, sia perché è un quadro cronico, sia perché il lieve aumento dei bicarbonati riesce a mantenere entro un range accettabile il pH, considerando anche la pCO₂ pari a 55, che rientra nella definizione di acidosi respiratoria (poiché superiore a 45) a pH "preservato".

Difficoltà: Media

Domanda 74: (codice domanda: ssm2023514)

I "criteri di Duke modificati" per la diagnosi di endocardite infettiva sono distinti in criteri maggiori e criteri minori. Tra i seguenti NON è un criterio maggiore:

- A: Fenomeni vascolari
- B: Significativa insufficienza valvolare di nuova insorgenza
- C: Ecocardiogramma positivo per nuova parziale deiscenza di protesi valvolare
- D: Due distinte emocolture positive per *Streptococcus bovis*
- E: Una singola emocoltura positiva per *Coxiella burnetii*

CC: I fenomeni vascolari (emboli arteriosi, infarti polmonari, aneurismi micotici, emorragia endocranica, emorragie congiuntivali e lesioni di Janeway) rientrano nei criteri di Duke minori. L'opzione B, C, D, E costituiscono invece i criteri maggiori.

Difficoltà: Facile

Domanda 75: (codice domanda: ssm2023515)

Un paziente con sintomi di meningite acuta presenta esami ematochimici nella norma. La rachicentesi evidenzia un liquor con una pressione di 35 cm H₂O, limpido, con



leucociti 460/mm³ (linfo-monociti 89%), protidorrachia 42 mg/dL e glicorrachia 56 mg/dL (con glicemia 88 mg/dL). Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Meningite da enterovirus
- B: Meningoencefalite da amebe a vita libera
- C: Meningite pneumococcica
- D: Meningoencefalite da *Cryptococcus neoformans*
- E: Meningite da *Haemophilus influenzae*

CC: Le caratteristiche del liquor (limpido, a prevalenza linfo-monocitaria, protidorrachia elevata, pressione e glicorrachia modesta) depongono per una meningite ad eziologia virale. Nella meningoencefalite da ameba a vita libera (*Naegleria Fowleri*) è possibile visionare i trofozoiti nel liquor il quale si manifesta in genere di colorito giallo-grigiastro, a predominanza polimorfonucleata e con GR, glucosio marcatamente ridotto, protidorrachia e pressione molto elevata (opzione B errata). La meningite pneumococcica si manifesta a liquor torbido, a prevalenza PMN e glucosio ridotto (opzione C errata) mentre la caratteristica principale della meningoencefalite da *C. neoformans* è l'elevata pressione liquorale. La meningite batterica da *H. influenzae* è tipica della fascia d'età 1-5 anni e mantiene le caratteristiche liquorali tipiche della meningite batterica. Inoltre con l'avvento della vaccinazione è molto meno frequente.

Difficoltà: Media

Domanda 76: (codice domanda: ssm2023516)

Un uomo di 75 anni con cardiopatia ischemica nota viene accompagnato in Pronto Soccorso per la comparsa nella notte di dispnea ingravescente. All'arrivo il paziente è vigile e tachi-dispnoico. All'auscultazione del torace si riscontano bilateralmente rumori umidi "a marea montante". La pressione arteriosa è 185/90 mmHg, la frequenza cardiaca è 130 bpm con PaO₂ 45 mmHg in area ambiente e pH 7,33. Quale tra i seguenti è il primo provvedimento da intraprendere?

- A: Ventilazione meccanica non invasiva
- B: Somministrazione di dopamina
- C: Posizionamento di lacci emostatici a rotazione sui quattro arti
- D: Somministrazione di furosemide per os
- E: Fluidoterapia

CC: Quadro clinico classico di edema polmonare acuto. Se non si è mai avuta l'opportunità di vedere un caso del genere, l'inquadramento diagnostico e l'approccio terapeutico possono non essere immediati, tuttavia il ragionamento può aiutarci. Andando per esclusione: l'infusione di fluidi in un edema polmonare, dove



fisiopatologicamente il problema è la congestione di liquidi a livello polmonare, può avere senso solo nel caso in cui è necessario sostenere il circolo (edema polmonare acuto a bassa gittata o in corso di shock settico, eventualità rara e di difficile gestione), quindi la fluidoterapia può essere esclusa. La dopamina, come agente vasopressore, non ha alcun ruolo nella gestione del caso considerando i valori di pressione arteriosa. Se qualcuno se lo chiedesse, l'uso di dopamina a basso dosaggio (dosaggio "renale") non sarebbe certamente uno dei primi provvedimenti da prendere nel caso specifico. La furosemide ha un ruolo centrale nella terapia dell'edema polmonare acuto, tuttavia si pratica preferenzialmente in boli endovenosi ed in infusione endovenosa per il più rapido onset di azione e non per os. Poco da dire sui lacci emostatici sui quattro arti, che è un distrattore. Rimane la ventilazione meccanica non invasiva, che può supportare l'inspirazione e mantenere gli alveoli espansi in espirazione e dunque favorire la ventilazione, gli scambi gassosi e la riduzione della congestione polmonare e va praticata fin dall'inizio della diagnosi clinica di edema polmonare acuto.

Difficoltà: Media

Domanda 77: (codice domanda: ssm2023517)

Un uomo di 30 anni viene rinvenuto in un giardino pubblico dal personale del 118 privo di coscienza, bradipnoico e con polso conservato. Sono evidenti segni di recente venopuntura ed è presente un laccio emostatico. Le pupille sono miotiche, la pressione è 90/60 mmHg. Il farmaco da somministrare tra i seguenti è:

- A: Naloxone
- B: Flumazenil
- C: Diazepam
- D: Pralidossima
- E: Fisostigmina

CC: Per rispondere a questa domanda, era sufficiente identificare il probabile agente causale del quadro clinico del paziente: verosimilmente ha fatto uso di droghe endovenose, il cui effetto è quello di deprimere il respiro e dare miosi pupillare (le cosiddette pupille a capocchia di spillo): tutto ciò porta a pensare a un'overdose da oppiacei. L'antagonista è pertanto il Naloxone, endovena o intranasale (ricordare sempre di tenere sotto osservazione il paziente a causa della breve emivita del farmaco e del possibile effetto rebound).

Difficoltà: Facile

Domanda 78: (codice domanda: ssm2023518)



Un uomo di 80 anni presenta da alcuni giorni febbre e otalgia per cui ha utilizzato antibiotico topico. Per la persistenza della sintomatologia il paziente si reca in Pronto Soccorso. Gli accertamenti laboratoristici rilevano una leucocitosi neutrofila e aumento della proteina C reattiva. Durante l'osservazione al PS il paziente sviluppa un picco febbrile con rigidità nucale e successiva riduzione dello stato di coscienza fino al coma. Tra le seguenti l'ipotesi più probabile è che il paziente abbia sviluppato:

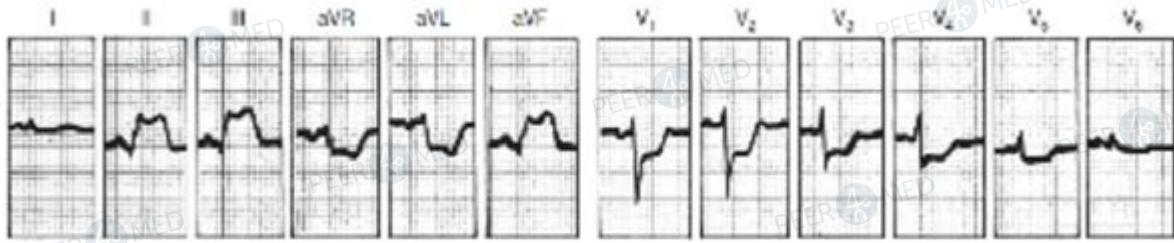
- A: Una meningite secondaria a otite da *Streptococcus pneumoniae*
- B: Uno "stroke" emorragico
- C: Una perforazione timpanica
- D: Uno stato di male epilettico
- E: Uno "stroke" ischemico

CC: La complicanza endocranica più grave di una otite batterica è l'estensione del processo infettivo al SNC determinando un quadro di meningite, che è in grado di pregiudicare la prognosi quoad vitam e causare sequele gravi. Il quadro clinico del paziente depone proprio per quest'ultima (rigor nuchalis, alterazione stato di coscienza, coma) e l'agente eziologico più comune è lo streptococco. Uno stroke ischemico o emorragico, pur determinando alterazione dello stato di coscienza sono eventi acuti che in genere non si manifestano con febbre ed elevati indici di flogosi (opzione B ed E errate). Una perforazione timpanica non implica una clinica di pertinenza neurologica e manca una storia di convulsioni per definire uno stato di male epilettico (opzione C e D errate).

Difficoltà: Facile

Domanda 79: (codice domanda: ssm2023519)

Un paziente di 56 anni si presenta in Pronto Soccorso con dolore diffuso in zona epigastrica. Appare ansioso, agitato, in cerca di una posizione per alleviare il dolore. Sono presenti sudorazione profusa, bradicardia, extrasistoli. L'accompagnatore ha riferito che il paziente accusava nausea e ha avuto 2 episodi di vomito alimentare circa 40 minuti prima. Si procede all'effettuazione di un ECG, emocromo, dosaggio enzimi specifici (Troponina, CPK, SGOT, LDH), RX torace, ecocardiogramma ed eco addome. Sono presenti leucocitosi ed iperglicemia. Si rimane in attesa del referto di enzimi specifici. Il referto dell'ECG è il seguente. Alla luce del quadro clinico ed elettrocardiografico, quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?



- A: STEMI
- B: Blocco di branca dx
- C: ECG nella norma
- D: Pericardite acuta
- E: NSTEMI

CC: Il quadro clinico ed ECG-grafico depone per sindrome coronarica acuta.

Considerando il sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni inferiori (II, III, aVF) già si può porre diagnosi di sindrome coronarica acuta con sopraslivellamento del tratto ST (STe-ACS). Il sottoslivellamento nelle precordiali (V1, V2, V3, V4) è un sottoslivellamento speculare da coinvolgimento della parete posteriore. Pertanto, si pone la diagnosi di STe-ACS infero-posteriore, che sarà più propriamente definibile STEMI infero-posteriore non appena si avrà la positività degli enzimi miocardiospecifici. La sintomatologia associata (bradicardia, extrasistoli, nausea e vomito alimentare) è tipica della condizione descritta. La risposta corretta è STEMI. La pericardite acuta si associa ad altri reperti clinici ed ECG-grafici (sottoslivellamento del tratto PR, sopraslivellamento con concavità rivolta verso l'alto del tratto ST). Il blocco di branca destra presenta una diversa morfologia (rSR' in V1, (q)Rs in V6) ed è clinicamente silente.

Difficoltà: Media

Domanda 80: (codice domanda: ssm2023520)

Una donna di 59 anni, nepalese, non fumatrice, giunta in Italia da circa un mese, si presenta dal medico con tosse, febbre, catarro ed un recente episodio di emottisi. Riferisce calo ponderale di 2 Kg negli ultimi 2 mesi, nessuna comorbidità. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Tubercolosi polmonare
- B: Infarto polmonare
- C: Edema polmonare
- D: BPCO
- E: Cuore polmonare acuto



CC: Febbricola serotina, tosse ed emottisi associata a calo ponderale in una paziente proveniente da un paese ad alta endemia, suggerisce la diagnosi di tubercolosi polmonare. Le altre opzioni (edema polmonare, BPCO e cuore polmonare acuto) si manifesterebbero con una clinica molto più acuta (come episodi di broncocostrizione e dispnea ingravescente) in assenza di emottisi, mentre un infarto polmonare oltre ad emottisi si associa spesso a dolore puntorio essendo caratterizzato in genere da consolidamenti in sede subpleurica.

Difficoltà: Facile

Domanda 81: (codice domanda: ssm2023521)

Un paziente di 65 anni, fumatore (40 pack-years), iperteso, con tosse anche produttiva, espettorato striato di sangue e dispnea si presenta in Pronto Soccorso. Non febbre, decubito indifferente, calo ponderale di 5 Kg nell'ultimo mese, senza variazione del regime alimentare. Sono stati eseguiti emocromo, ECG, RX torace e il dosaggio del BNP che risulta 80 pg/mL. In attesa degli altri referti, quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Carcinoma polmonare
- B: Scompenso cardiaco congestizio
- C: Edema polmonare
- D: Cardiopatia ischemica
- E: Pneumotorace

CC: L'anamnesi di paziente 65enne, forte fumatore con emottisi e calo ponderale senza variazione del regime alimentare fa propendere per un patologia oncologica. L'esito del BNP non elevato corrobora il sospetto in quanto in caso di scompenso cardiaco congestizio o edema polmonare tale valore risulterebbe molto elevato e la clinica avrebbe avuto un esordio più acuto. Manca inoltre il dolore toracico tipico in caso di cardiopatia ischemica o pneumotorace.

Difficoltà: Facile

Domanda 82: (codice domanda: ssm2023522)

Un paziente di 80 anni, iperteso e diabetico giunge in Pronto Soccorso accusando da alcune ore afasia, capogiri, difficoltà alla deambulazione, deviazione della rima buccale. Il quadro clinico regredisce dopo circa un'ora. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Attacco ischemico transitorio



- B: Infarto cerebrale
- C: Tumore cerebrale
- D: Ematoma cerebrale
- E: Emorragia subaracnoidea

CC: Un attacco ischemico transitorio (TIA sta per transient ischemic attack) si caratterizza per una temporanea interruzione o riduzione dell'afflusso del sangue al cervello. Dura pochi minuti e generalmente non provoca danni permanenti. Il quadro clinico potrebbe sembrare un ictus tuttavia la sintomatologia regredisce, questo ci sposta quindi la diagnosi verso un TIA. Non abbiamo inoltre abbastanza informazioni per poter parlare di ematoma o emorragia perchè servirebbe una TAC cranio che il testo non ci da.

Difficoltà: media

Domanda 83: (codice domanda: ssm2023523)

Un paziente di 68 anni lamenta astenia e dispnea. All'esame obiettivo presenta toni cardiaci parafonici, pressione arteriosa 90/70 mmHg che cala ulteriormente in fase espiratoria, turgore delle vene giugulari. All'ECG si rilevano alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Versamento pericardico
- B: Dissezione aortica
- C: Cardiomiopatia ipertrofica
- D: Miocardite acuta
- E: Ischemia miocardica acuta

CC: Lo scenario presente il quadro clinico tipico di un versamento pericardico, infatti possiamo riscontrare i sintomi tipici della triade di beck (ipotensione, turgore giugulare, toni parafonici).

Difficoltà: Facile

Domanda 84: (codice domanda: ssm2023524)

Un uomo di 86 anni, in terapia per scompenso cardiaco cronico, lamenta da alcuni giorni dispnea ingravescente, ortopnea e comparsa di edemi declivi. Riferisce di non aver assunto con regolarità la terapia domiciliare. Quale tra i seguenti farmaci deve essere rapidamente reintrodotta con contestuale rivalutazione della posologia?

- A: Diuretico dell'ansa
- B: Antiaggregante piastrinico



- C: Beta bloccante
- D: ACE inibitore
- E: Calcio antagonista

CC: Il paziente presenta un peggioramento della sintomatologia da scompenso per via di una mancata compliance alla terapia. Il farmaco migliore per il controllo dei sintomi ma non della progressione della scompenso è proprio il diuretico dell'ansa

Difficoltà: Media

Domanda 85: (codice domanda: ssm2023525)

Al primo riscontro di fibrillazione atriale persistente quale score tra i seguenti può essere utilizzato per determinare la necessità di terapia anticoagulante?

- A: CHA2DS2-VASc
- B: Wells
- C: Geneva
- D: CURB
- E: SOFA

CC: Domanda nozionistica. Lo score che viene utilizzato per stabilire la necessità di terapia anticoagulante a lungo termine dopo il primo episodio di fibrillazione atriale, in prevenzione dell'ictus cardioembolico è il CHA2DS2-VASc. Lo score di Wells e il Geneva Score sono utilizzati per stabilire la probabilità di embolia polmonare. Il CURB è uno score prognostico per le polmonite comunitarie, utile per stabilire il setting assistenziale. Il SOFA score serve per la diagnosi e il monitoraggio della sepsi.

Difficoltà: Facile

Domanda 86: (codice domanda: ssm2023526)

Nella malattia del rene policistico autosomica dominante (ADPKD) quale tra le seguenti è una lesione extrarenale tipica:

- A: Aneurismi cerebrali
- B: Cisti sebacee
- C: Sordità
- D: Alterazioni corneali
- E: Alterazioni ungueali

CC: Domanda nozionistica. L'ADPKD è causata da una mutazione che predispone alla formazione progressiva dalla giovane età di cisti renali multiple che portano a insufficienza renale cronica. La malattia è caratterizzata anche da una serie di manifestazioni extrarenali: aneurismi cerebrali (presenti nel 10% dei pazienti anziani),



aneurismi coronarici, anomalie valvolari cardiache, aneurisma dell'aorta, cisti epatiche, manifestazioni intestinali. Non si associa invece ad anomalie dermatologiche o a sordità.

Difficoltà: Media

Domanda 87: (codice domanda: ssm2023527)

Una paziente di 36 anni si presenta in Pronto Soccorso con forti dolori trafittivi al quadrante addominale inferiore sx e al fianco sx che si irradiano al dorso e all'inguine. Manovra di Giordano positiva. Nausea e vomito. Nessuna comorbidità. Pressione arteriosa 150/80 mmHg, 101 bpm, SpO2 99% in aria ambiente. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Colica renale
- B: Colica biliare
- C: Gravidanza extrauterina
- D: Appendicite acuta
- E: Pancreatite acuta

CC: La domanda richiede di effettuare una diagnostica differenziale tra alcune possibili cause di addome acuto. La tipologia di dolore, la sua localizzazione, l'irradiazione all'inguine, la positività della manovra di Giordano depongono per un episodio di colica biliare.

Difficoltà: Media

Domanda 88: (codice domanda: ssm2023528)

Nella sindrome da lisi tumorali le seguenti manifestazioni sono tutte tipiche TRANNE una, quale?

- A: Iperglicemia
- B: Iperuricemia
- C: Iperpotassiemia
- D: Aumento della creatininemia
- E: Iperfosforemia

CC: La Sindrome da lisi tumorale è una comune complicanza all'esordio o all'inizio del trattamento di alcune neoplasie (soprattutto leucemie e linfomi aggressivi). È caratterizzata da lisi massiva delle cellule tumorali con rilascio di potassio (Iperpotassiemia), fosfati (iperfosfatemia e ipocalcemia secondaria al legame del calcio col fosfato) e cataboliti purinici (convertiti in acido urico con conseguente iperuricemia). L'iperuricemia può determinare insufficienza renale acuta. L'iperglicemia non fa parte delle manifestazioni classiche.



Difficoltà: Media

Domanda 89: (codice domanda: ssm2023529)

Un paziente di 65 anni affetto da ipertensione arteriosa da diversi anni si presenta ad una prima valutazione nefrologica ambulatoriale per recente insorgenza di edemi declivi. Allo stick urine è presente una albuminuria di 300 mg/dL. Quale tra i seguenti gruppi di esami di approfondimento è più opportuno in prima istanza?

A: Emocromo, indici di funzionalità renale, elettroliti completi, assetto lipidico, elettroforesi siero-proteica, esame urine, proteinuria delle 24 h

B: Assetto lipidico, indici di funzionalità renale, enzimi epatici, indici di colestasi, bilirubinemia totale e frazionata, omocisteinemia

C: Emocromo, indici di funzionalità renale, elettroliti completi e test di Farley

D: Emocromo con reticolociti, volume di filtrazione glomerulare, uricemia, elettroliti completi, assetto marziale, PTH

E: Test genetico per le podocitopatie

CC: Nel sospetto clinico di sindrome nefrosica (albuminuria su esame spot delle urine ed edemi declivi) gli esami indicati sono esami di funzionalità renale ed elettroliti, esame urine e preproteinuria delle 24h, profilo lipidico (spesso la sindrome nefrosica si associa a dislipidemia) ed elettroforesi sieroproteica (la sindrome nefrosica si associa a ipogammaglobulinemia e ipoalbuminemia). L'emocromo è richiesto anche per escludere una proteinuria secondaria a discrasia plasmacellulare. Il mieloma multiplo è caratterizzato da gammopatia monoclonale, ipercalcemia, lesioni ossee, anemia e insufficienza renale (sintomi CRAB) oltre che da possibile proteinuria dovuta alle catene leggere del picco monoclonale.

Difficoltà: Media

Domanda 90: (codice domanda: ssm2023530)

L'attuale stadiazione della malattia renale cronica secondo le linee guida internazionali e nazionali:

A: Prevede la suddivisione in stadi di malattia renale inaggravante secondo il filtrato glomerulare stimato o misurato

B: Necessita di valutazione ecografica della morfologia renale con valutazione dello spessore cortico-midollare

C: Non riconosce gli stadi precoci in cui sono presenti segni di patologia renale ma non di compromissione funzionale

D: Riconosce la presenza di 3 stadi di malattia renale cronica lieve, moderata e severa sulla base dei valori di creatininemia



E: Può essere utilizzata solo nei pazienti con diagnosi istologica di nefropatia cronica

CC: La malattia renale cronica secondo l'attuale classificazione è suddivisa in 5 stadi in base al solo valore di GFR. Gli stadi iniziali possono essere clinicamente silenti.

- Stadio 1: velocità di filtrazione glomerulare normale (≥ 90 mL/min/1,73 m²) più o albuminuria persistente o nota malattia strutturale o ereditaria renale
- Stadio 2: velocità di filtrazione glomerulare 60-89 mL/min/1,73 m²
- Stadio 3a: 45-59 mL/min/1,73 m²
- Stadio 3b: 30-44 mL/min/1,73 m²
- Stadio 4: velocità di filtrazione glomerulare 15-29 mL/min/1,73 m²
- Stadio 5: velocità di filtrazione glomerulare < 15 mL/min/1,73 m²

Difficoltà: Facile

Domanda 91: (codice domanda: ssm2023531)

In una paziente di 63 anni con recente diagnosi di adenocarcinoma gastrico di tipo intestinale, metastatico a livello epatico e polmonare, la valutazione immunoistochimica sul tessuto neoplastico ha documentato l'iperespressione di HER-2. E' stata posta l'indicazione ad eseguire un trattamento chemioterapico di prima linea. Quale terapia a bersaglio molecolare è indicato associare al trattamento chemioterapico?

- A: Trastuzumab
- B: Panitumumab
- C: Bevacizumab
- D: Cetuximab
- E: Rituximab

CC: Domanda nozionistica. L'anticipo monoclonare anti-HER2 è il trastuzumab, utilizzato nel carcinoma mammario HER-positivo oltre che nel carcinoma gastrico. Il Panitumumab e Cetuximab sono anti-EGFR utilizzati in alcuni tumori gastrointestinali. Rituximab è anti-CD20 utilizzato nel trattamento di alcune patologie linfoproliferative e malattie autoimmuni. Bevacizumab è anti-VEGF utilizzato in alcuni tumori ad elevata vascolarizzazione come il tumore del rene.

Difficoltà: Media

Domanda 92: (codice domanda: ssm2023532)

Il pembrolizumab è un farmaco immunoterapico indicato nel trattamento di numerosi tumori solidi in fase metastatica come tumore polmonare non-microcitoma, melanoma, carcinoma uroteliale, carcinoma renale, carcinoma testa/collo. Che tipo di anticorpo è?



- A: E' un anticorpo monoclonale anti-PD1
- B: E' un anticorpo monoclonale anti-VEGF
- C: E' un anticorpo monoclonale anti-TIGIT
- D: E' un anticorpo monoclonale anti-HER-2
- E: E' un anticorpo monoclonale anti-CTLA4

CC: Il Pembrolizumab è un anticorpo monoclonale anti PD1 che inibisce il cosiddetto meccanismo dei checkpoint inhibitor, permettendo al sistema immunitario di sbloccare la sua azione contro le cellule neoplastiche.

Difficoltà: Difficile

Domanda 93: (codice domanda: ssm2023533)

A seguito della comparsa di ittero, una paziente di 61 anni in buone condizioni cliniche generali esegue degli accertamenti diagnostici che si concludono con una diagnosi di tumore della testa del pancreas. La paziente viene sottoposta ad intervento chirurgico di duodenocefalopancreasectomia e l'esame istologico depone per "adenocarcinoma della testa del pancreas". La stadiazione è pT2pN1M0. Quale trattamento medico è più indicato?

- A: Chemioterapico adiuvante secondo lo schema FOLFIRINOX
- B: Chemioterapico adiuvante secondo lo schema CHOP
- C: Chemioterapico adiuvante secondo lo schema Ciclofosfamida-Adriamicina
- D: Immunoterapico adiuvante con Atezolizumab
- E: Chemioterapico adiuvante con Topotecan

CC: Un tumore del pancreas pT2pN1M0 è un tumore che ha una grandezza tra 2 e 4 cm con metastasi da 1 a 3 linfonodi regionali. Nei pazienti con età sotto ai 70 anni il FOLFIRINOX andrebbe preso in considerazione come primo trattamento in alternativa alla monoterapia con Gemcitabina

Difficoltà: Difficile

Domanda 94: (codice domanda: ssm2023534)

Un uomo di 27 anni lamenta da circa 2 anni dolore lombare irradiato ai glutei. La sintomatologia è accentuata al risveglio e migliora progressivamente nell'arco della giornata. Gli esami mostrano moderato incremento degli indici di flogosi ma la radiografia del bacino e del rachide lombosacrale non evidenziano alterazioni di rilievo. Quale tra questi esami è più indicato effettuare?



- A: RM bacino
- B: TC bacino
- C: TC rachide lombosacrale
- D: Ecografia rachide lombosacrale
- E: Biopsia osteomidollare

CC: In base al quadro clinico e ai dati epidemiologici in nostro possesso potevamo giungere al sospetto di spondilite anchilosante: questa è un'artropatia cronica, che colpisce la popolazione generale (perlopiù maschile) con un picco di incidenza fra i 15 e i 40 anni. Il dolore tipicamente è più intenso al mattino, dopo un riposo prolungato (quello notturno) e si riduce con l'attività fisica, e nel caso clinico viene descritta la "sciatica mozza": dolore lombare irradiato ai glutei fino alla coscia, solitamente. La diagnosi si avvale di esami di laboratorio (FR sempre assente, incremento degli indici di flogosi, associazione nel 90% dei casi con HLA B-27) ed indagini radiologiche: qualora esse risultino negative, come in questo caso, si può ricorrere alla RM, che rivela precocemente le alterazioni sacro iliache.

Difficoltà: Facile

Domanda 95: (codice domanda: ssm2023535)

Un uomo di 34 anni presenta da circa due mesi febbre intermittente accompagnata a faringodinia. Durante gli episodi ha notato un rash color salmone sul tronco e sulle braccia. Agli esami di laboratorio si evidenzia un incremento degli indici di flogosi ed un marcato aumento dei valori di ferritina. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Malattia di Still dell'adulto
- B: Artrite reumatoide
- C: Sclerosi sistemica
- D: Dermatomiomiosi
- E: Polimialgia reumatica

CC: Parola chiave in questo quesito: rash color salmone. Unitamente all'età e sintomatologia del paziente, poteva condurre alla soluzione, che è il Morbo di Still, classificato fra le Artriti croniche giovanili, definiti come quadri che insorgono da almeno 12 settimane, senza predilezione di sesso, con sintomi sistemici (febbre, linfadenopatia, epatosplenomegalia e polisierositi), rash cutaneo (con macule rosa pallido di estensione variabile, su tronco, estremità prossimali di arti e volto).

Difficoltà: Facile



Domanda 96: (codice domanda: ssm2023536)

Una donna di 60 anni affetta da diabete mellito di tipo 1 dall'età di 28 anni, complicato da retinopatia e nefropatia diabetica, ha un colesterolo LDL=130 mg/dL, in assenza di terapia ipolipemizzante. Secondo le linee guida ESC del 2019, il suo target dovrebbe essere:

- A: LDL<55 mg/dL
- B: LDL<70 mg/dL
- C: LDL<100 mg/dL
- D: LDL<116 mg/dL
- E: LDL<130 mg/dL

CC: I fattori da prendere in considerazione sono il sesso, il colesterolo non HDL, il fumo, la pressione arteriosa e l'età. Nel nostro caso la paziente presenta un rischio alto e quindi le LDL<55 mg/dL

Difficoltà: Media

Domanda 97: (codice domanda: ssm2023537)

Un paziente di anni 80, si presenta al Pronto Soccorso per la comparsa acuta, circa due ore prima, di ipostenia dell'emisoma di destra. Obiettività neurologica: paziente vigile, collaborante; deficit di forza agli arti di destra con caduta precoce alla manovra di Mingazzini, lieve deficit del linguaggio con anomalie. L'indagine diagnostica da effettuare immediatamente è:

- A: TC cerebrale con studio angiografico dei vasi cerebrali
- B: Spettroscopia con RM cerebrale
- C: Ecodoppler dei tronchi sopraortici
- D: Angiografia cerebrale
- E: Elettroencefalogramma

CC: Classico esempio di evento acuto neurologico. Il paziente, dato lo spettro e la tempistica dei sintomi, quasi certamente avrà una lesione ischemica in atto dell'emisfero sinistro, più in particolare un'occlusione di un tratto della cerebrale media. L'unica opzione che avrebbe potuto trarvi in inganno (e che per fortuna non vi hanno messo) sarebbe stata la TC encefalo senza mdc, in quanto anche con la quasi certezza di un evento ischemico in atto, la prima cosa da fare è sicuramente una passata "in bianco" per escludere un ictus emorragico (20% circa degli ictus all'esordio), in quanto il MdC potrebbe coprire il sangue fresco anch'esso iperdenso. Nella pratica clinica tutto ciò avviene in contemporanea alla risposta corretta A, ovvero il Paziente entra in TC, fa una passata in basale, gli viene iniettato il contrasto e si fa l'angio-TC del distretto



intracranico (con associato studio perfusionale); in questo modo si può individuare un'eventuale occlusione di un vaso (su base trombotica per lo più, ma anche dissecante ecc...) e dirimere poi la scelta terapeutica successiva (fibrinolisi? studio angiografico diagnostico e/o terapeutico in angiografica? watch and wait?). La risposta C non ha senso in emergenza; la E non ha senso punto. Ricordatevi che la B è molto utile nello studio in elezione per quelle lesioni di natura tumorale dubbia, eventualmente insieme ad uno studio perfusionale. Risposta corretta A.

Difficoltà: Facile.

Domanda 98: (codice domanda: ssm2023538)

Paziente di 45 anni moderatamente iperteso in trattamento farmacologico con antipertensivi. Da circa una settimana presenta episodi caratterizzati da clonie che interessano inizialmente la mano destra e si estendono successivamente all'emivolto omolaterale. Gli episodi durano circa 30 secondi e sono seguiti da una perdita di forza che persiste per diverse ore. Quale tra le seguenti è l'ipotesi diagnostica più probabile?

- A: Epilessia parziale motoria
- B: Esordio di una sindrome extrapiramidale
- C: Espressione di ischemie cerebrali focali transitorie
- D: Miopatia
- E: Ischemie midollari

CC: Il quesito ci chiede di identificare quale di queste patologie può dare degli episodi parossistici di breve durata. Si esclude la E, poiché se la sede fosse midollare, non ci sarebbe l'interessamento del volto. Anche la C deve essere esclusa per diverso motivo: innanzitutto, le ischemie, normalmente, causano una sintomatologia negativa (e non positiva con delle clonie, cioè movimenti ripetitivi di uno o più segmenti); inoltre, è poco verosimile che un individuo faccia delle ischemie nello stesso territorio più e più volte; inoltre, gli episodi ischemici durano maggiormente. B e D sono anch'esse da escludere, poiché si tratta di patologie progressive, che peggiorano con l'andare del tempo, senza risoluzione. La A è la risposta corretta, verosimilmente a partenza dall'area motoria della mano, con estensione all'opercolo frontale (tipica marcia jacksoniana), con conseguente iperpolarizzazione neuronale e paralisi di Todd; gli episodi sono transitori, a risoluzione spontanea.

Difficoltà: Facile.

Domanda 99: (codice domanda: ssm2023539)

Una ragazza di 20 anni si presenta all'osservazione dei sanitari in merito ad un disturbo caratterizzato da parestesie localizzate simmetricamente a livello distale nei 4 arti.



Interrogata, riferisce che i sintomi sono comparsi il giorno precedente ma stanno progredendo per intensità. Due settimane prima dell'esordio dei sintomi, viene segnalata una gastroenterite regredita dopo circa cinque giorni. All'esame obiettivo neurologico, gli unici elementi di rilievo riguardano una ipoestesia distale agli arti inferiori e superiori e assenza dei riflessi achillei bilateralmente, con ipoevocabilità di tutti gli altri riflessi osteotendinei. L'ipotesi diagnostica più probabile tra le seguenti è:

- A: Poliradiculonevrite acuta (S. di Guillain-Barré)
- B: Esordio di una Sclerosi Multipla
- C: Ictus vertebrobasilare
- D: Intossicazione da benzodiazepine
- E: Compressione midollare (S. Brown-Séquard)

CC: La sintomatologia e la clinica riportate nella domanda sono espressione di un coinvolgimento periferico (areflessia, ipoestesia simmetrica ai quattro arti), dunque sono da escludere in prima battuta la B e la C. La D avrebbe causato un'alterazione dello stato di coscienza, atassia, depressione respiratoria, nistagmo, miosi, che non sono riportati nel caso clinico. La E non può essere corretta poiché si tratta di un disturbo normalmente post-traumatico midollare, caratterizzato da ipoestesia tattile e paresi ipsilaterale al danno, e ipoestesia protopatica e termodolorifica controlaterale. Invece la simmetria e la precedente gastroenterite ci fanno propendere più per una Guillain-Barré (risposta A).

Difficoltà: Facile.

Domanda 100: (codice domanda: ssm2023540)

La Disforia di genere può essere definita come:

- A: Il disagio affettivo tra il ruolo, il genere espresso dall'individuo e il sesso attribuito alla nascita
- B: Un comportamento che si osserva in un adolescente maschio eterosessuale che utilizza uno o più indumenti femminili per eccitarsi sessualmente e masturbarsi da solo o in uno scambio con un partner
- C: Un timore o un pensiero dell'adolescente che pensa di essere attirato da persone dello stesso sesso
- D: Una condizione caratterizzata soprattutto dalla ambiguità degli organi genitali esterni e si possono distinguere due categorie principali: lo pseudoermafroditismo femminile, più frequente, e quello maschile
- E: Una condotta psicopatica che si accompagna ad altre manifestazioni come la prostituzione e la tossicodipendenza



CC: Questa domanda poteva essere risolta per esclusione rispetto a due opzioni che proponevano rispettivamente dei comportamenti "estremi" in associazione (la prostituzione, tossicodipendenza) e la limitazione al comportamento in un maschio adolescente eterosessuale, dato che la disforia di genere riguarda ambo i sessi. In particolare, essa è un disagio clinicamente significativo con possibile compromissione funzionale, diagnosticabile se questi disturbi persistono per almeno 6 mesi. Il trattamento mira ad alleviare il disagio e la compromissione funzionale.

Difficoltà: Facile

Domanda 101: (codice domanda: ssm2023541)

Un paziente di 48 anni giunge in Pronto Soccorso trasportato dal 118 che è stato allertato da un familiare del paziente in seguito ad episodio delirante acuto (il paziente sospettava che la compagna lo tradisse) associato ad uno stato di agitazione psico-motoria. La compagna del paziente è molto preoccupata perché nell'ultima settimana aveva notato cambiamenti comportamentali con insorgenza di insonnia, ansia libera, manie di persecuzione e deficit attentivi. In anamnesi nulla di rilevante, nega familiarità per patologie neurologiche e/o psichiatriche. Viene riferita una febbre con astenie e mialgie insorte da circa due settimane e durata di tre giorni. All'esame obiettivo si evidenzia disorientamento spazio-temporale, difficoltà nella comprensione delle consegne e nel reperimento dei vocaboli in un contesto di obiettività internistica nella norma. Qual è il percorso diagnostico più appropriato?

- A: RM encefalo con MdC + EEG
- B: RM encefalo senza MdC
- C: TC cerebrale senza MdC
- D: Potenziali evocativi visivi
- E: Angio-RM encefalo

CC: La comparsa improvvisa dei sintomi, il fatto che il paziente non soffra e non abbia familiarità per patologie neurologiche e/o psichiatriche, l'associazione con febbre con astenie e mialgie ci fanno indirizzare innanzitutto verso una sindrome organica, che indaghiamo in prima battuta con RM con mezzo di contrasto ed EEG.

Difficoltà: Media

Domanda 102: (codice domanda: ssm2023542)

Qual è il farmaco più indicato come stabilizzatore dell'umore nel trattamento di pazienti affetti da sindrome bipolare di tipo I?

- A: Acido valproico



- B: Fluoxetina
- C: Venlafaxina
- D: Carbamazepina
- E: Pregabalin

CC: Il disturbo bipolare di tipo 1 è caratterizzato dall'alternanza tra fasi di Mania (caratterizzate da euforia/aggressività, comportamento esplosivo, alterate funzioni psicomotorie, della durata pari o superiore a una settimana) e di Ipomania (caratterizzate da umore talvolta allegro o depresso/ irritabile, con funzioni psicomotorie preservate, della durata pari o superiore a 4 giorni, in assenza di sintomi psicotici). durante la fase acuta in particolare si impiegano stabilizzatori dell'umore, soprattutto il valproato (si ricordi che è teratogeno), e la carbamazepina per stati acuti di mania e stati misti (mania e depressione).

Difficoltà: Media

Domanda 103: (codice domanda: ssm2023543)

La scintigrafia miocardica è indicata per studiare:

- A: Perfusione cardiaca
- B: Ipertensione arteriosa
- C: Tumori cardiaci
- D: Infezione di valvole cardiache
- E: Rottura di muscolo papillare

CC: La scintigrafia miocardica è un esame diagnostico non invasivo che consente di raccogliere informazioni sul funzionamento del cuore. L'esame prevede la somministrazione di un radiofarmaco debolmente radioattivo che si fissa a livello del muscolo cardiaco. Le immagini acquisite da un'apparecchiatura chiamata gamma-camera vengono elaborate e interpretate dal medico nucleare e dal cardiologo che ha effettuato la prova e danno informazioni sullo stato di perfusione del cuore e sui vari parametri relativi al suo funzionamento.

Difficoltà: Facile

Domanda 104: (codice domanda: ssm2023544)

In un paziente con recidiva biochimica da carcinoma prostatico, sottoposto a prostatectomia radicale, quale indagine tra le seguenti è più indicata per la identificazione di tutte le possibili sedi di malattia?

- A: PET/TC con ^{68}Ga -PSMA
- B: PET/TC con ^{18}F -FDG
- C: PET/TC con ^{18}F -DOPA



D: Scintigrafia ossea

E: PET/TC con 68Ga-DOTA-peptidi (DOTATATE, DOTATOC, DOTANOC)

CC: Per la PET/CT total body con 68Ga-PSMA viene utilizzato un radiofarmaco, il 68Ga-PSMA, che si localizza in modo selettivo a livello delle cellule di origine prostatica, in particolare in quelle tumorali. Il fluoro-desossiglucosio (18F-FDG), analogo marcato del glucosio, che permette di valutare in modo efficace, tra gli altri aspetti, il comportamento metabolico (spesso correlato al grado di aggressività o di differenziazione) di un tumore, nonché l'effetto dei trattamenti chemio o radioterapici sull'evoluzione del tumore stesso. La PET/TC con 18F-DOPA è un esame diagnostico che prevede l'iniezione endovenosa di un radiofarmaco (18F-fluoro-di-idrossi-fenil-alanina). Questo radiofarmaco è un aminoacido marcato con un isotopo debolmente radioattivo il cui utilizzo prevede applicazione sia in ambito cerebrale (studio funzionale dei gangli della base) sia in ambito oncologico nelle neoplasie derivanti dalla cresta neurale (carcinoidi, carcinoma midollare della tiroide, feocromocitoma e neuroblastoma). Infine il 68Ga-DOTA-peptidi (DOTATATE, DOTATOC, DOTANOC) sono usati nello studio dei tumori neuroendocrini ben differenziati.

Difficoltà: Difficile

Domanda 105: (codice domanda: ssm2023545)

I 68Ga-DOTA-peptidi (DOTATATE, DOTATOC, DOTANOC) sono radiofarmaci PET impiegati routinariamente per lo studio:

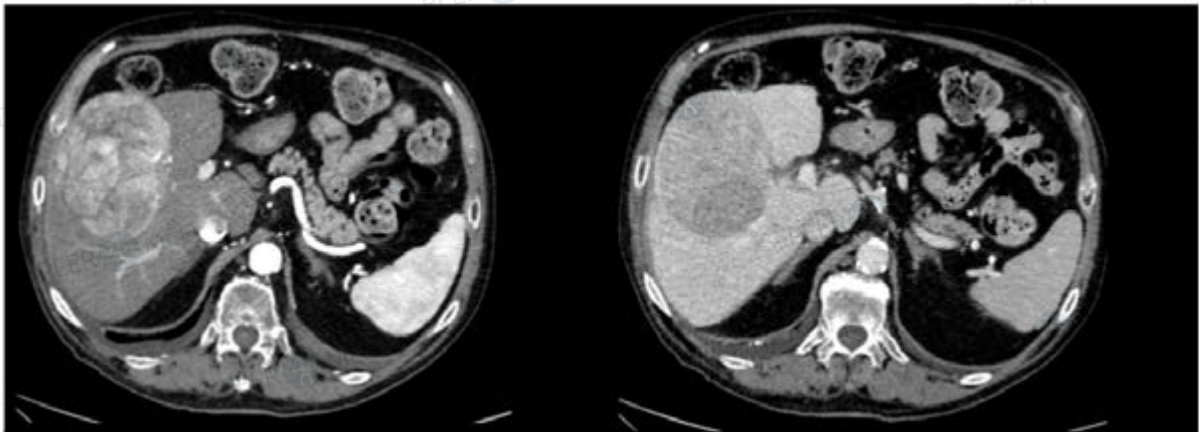
- A: Dei tumori neuroendocrini ben differenziati
- B: Dei disturbi del movimento
- C: Dei carcinomi squamo-cellulari
- D: Dei carcinomi della prostata
- E: Dell'amiloidosi cardiaca

CC: I peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA sono una serie di composti radiomarcanti analoghi dell'octreotide, un octapeptide sintetico analogo della somatostatina in grado di mimare la sua azione legandosi ai recettori della somatostatina (SSTRs) con una maggiore affinità rispetto all'ormone endogeno. Essi possono essere appunto utilizzati nello studio dei tumori neuroendocrini ben differenziati.

Difficoltà: Difficile

Domanda 106: (codice domanda: ssm2023546)

Paziente HBsAg positivo con recente riscontro di massa palpabile in addome, esegue TC con MdC e.v. che evidenzia una lesione epatica sospetta per una diagnosi di epatocarcinoma. Qual è il comportamento contrastografico tipico dell'epatocarcinoma?



- A: Wash-in arterioso con wash-out portale-tardivo
- B: Wash-in portale e wash-out arterioso
- C: Enhancement centripeto progressivo
- D: Assenza di contrast-enhancement
- E: L'epatocarcinoma non presenta un pattern contrastografico specifico

CC: L'HCC risulta essere una delle lesioni focali epatiche caratterizzate da un comportamento contrastografico relativamente tipico (relativamente in quanto, come ogni cosa in medicina, esistono forme classiche e forme atipiche), ovvero una precoce impregnazione contrastografica in fase arteriosa (precoce "wash-in"), ed un "wash.out" di contrasto in fase venosa, essendo per definizione una lesione tumorale estremamente vascolarizzata (risposta corretta A, risposta D ed E errate). La risposta B non ha senso in quanto la fase portale è successiva a quella arteriosa. L'enhancement centripeto progressivo diciamo essere caratteristica delle lesioni focali come FNH e anche alcuni tipi di adenoma (risposta C errata).

Difficoltà: Difficile.

Domanda 107: (codice domanda: ssm2023547)

Donna di 22 anni, accede al Pronto Soccorso per incidente stradale. Riferisce dolore addominale diffuso. PA: 130/70 mmHg, SpO2 97% in aria ambiente. ECO-FAST dubbia. Qual è l'indagine più appropriata per l'inquadramento diagnostico terapeutico tra le seguenti?

- A: TC spirale dell'addome con MdC
- B: Esame diretto dell'addome
- C: Ecografia con MdC
- D: Laparoscopia esplorativa
- E: RM whole body

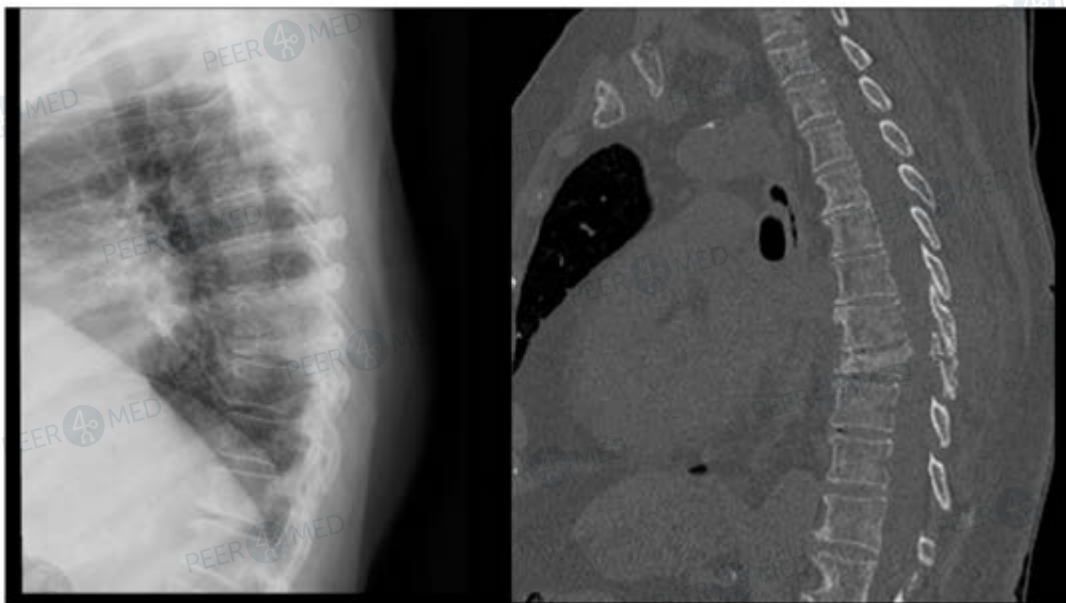


CC: Nonostante il testo non ci dica se l'incidente sia stato ad alta o bassa energia, e nonostante i parametri vitali siano buoni, ci dice che l'eco-fast fatta in PS è "dubbia"; con tutte queste premesse è chiaro che il caso clinico non possa essere lasciato così, ma debba essere approfondito per escludere eventuali emorragie interne o comunque lesioni misconosciute all'ecografia o persino occulte. L'unica opzione tra quelle proposte in grado di fare ciò è la TC con mdc (risposta corretta A). L'esame diretto dell'addome si usa come primissimo esame nel caso di sospetta occlusione intestinale (risposta B errata); l'ecografia con MdC non ha senso in emergenza e trova spazio principalmente nello studio delle lesioni focali epatiche (risposta C errata); la laparoscopia esplorativa senza imaging si può fare solamente nel Paziente estremamente instabile dal pdv emodinamico (risposta D errata); la RM whole body in emergenza non trova molto impiego, soprattutto in questo caso clinico.

Difficoltà: Facile.

Domanda 108: (codice domanda: ssm2023548)

Paziente di 87 anni con dolore in regione dorsale. Quali reperti di rilievo si possono evidenziare in queste immagini RX e TC?



- A: Crollo vertebrale dorsale
- B: Crollo vertebrale lombare
- C: Dissezione dell'aorta
- D: Morbo di Paget
- E: Ernia discale

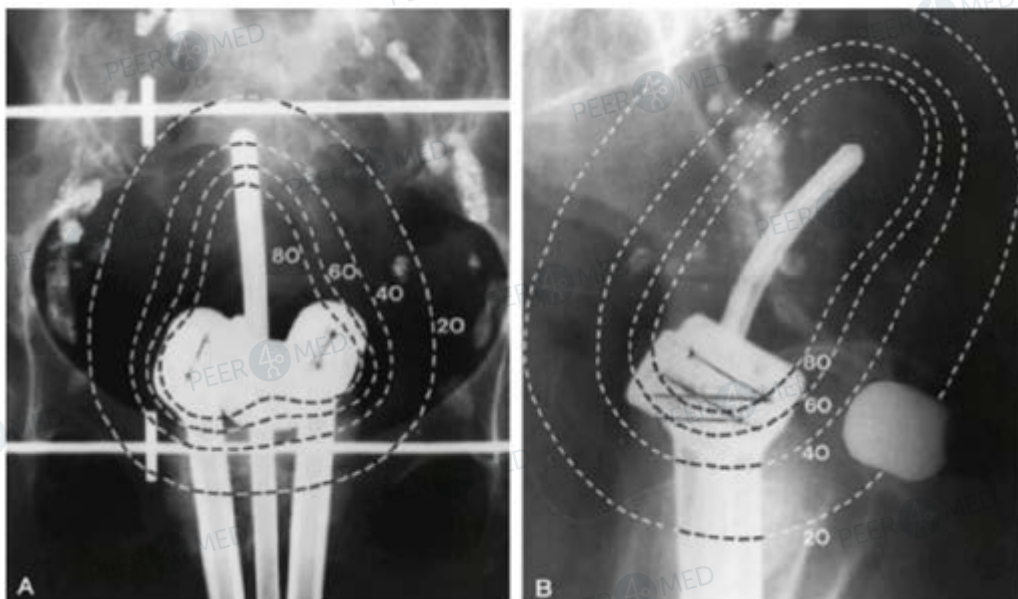


CC: Le due immagini sono un RX rachide dorsale ed una TC rachide dorsale con kernel per osso (risposta B errata), e la regione anatomica si può evincere dalle strutture adiacenti come il torace, i polmoni, il cuore ecc. Quello che salta all'occhio è ovviamente una riduzione dell'altezza di un soma rachideo, estremamente assottigliato e con una morfologia "a cuneo", tipica dei crolli vertebrali (risposta corretta A). La dissezione dell'aorta si scarta in quanto non è un esame di angio-TC (né tantomeno la finestra giusta). Per poter fare diagnosi di ernia discale ad una TC, ci vuole la finestra per tessuti molli e non per osso (oltre al fatto di dover acquisire ad uno strato molto sottile, motivo per cui si preferisce di gran lunga l'RM, risposta E errata). La risposta D è errata in quanto nel Paget io ho un rimaneggiamento osseo importante (alternanza di zone osteoaddensate e rarefatte) che possono anche portare a modificazioni dei somi vertebrali, ma non è questa la presentazione tipica (risposta D errata).

Difficoltà: Media.

Domanda 109: (codice domanda: ssm2023549)

Una paziente di 56 anni è affetta da carcinoma squamocellulare della cervice uterina, inoperabile per estesa infiltrazione dei parametri. Il trattamento programmato consiste in una chemioradioterapia. La radioterapia è effettuata con irradiazione della regione pelvica seguita dal posizionamento nella vagina e nell'utero di un applicatore caricato con sorgenti di iridio-192, come riportato in figura. Come si definisce quest'ultima tecnica di trattamento?



A: Brachiterapia intracavitaria



- B: Radioterapia esterna
- C: Radioterapia intraoperatoria
- D: Radio-immunoterapia
- E: Brachiterapia interstiziale

CC: Domanda teorica. L'utilizzo di dispositivi lasciati in sede per rilasciare radiazioni terapeutiche si chiama brachiterapia (a differenza della radioterapia convenzionale in cui le radiazioni vengono somministrate dall'esterno tramite un acceleratore lineare). Essendo il dispositivo posto all'interno di un organo cavo si tratta di brachiterapia intracavitaria.

Difficoltà: Facile

Domanda 110: (codice domanda: ssm2023550)

Uomo, 63 anni, ex calciatore professionista, oggi allenatore, effettua una visita per idoneità sportiva. Nessuna malattia in anamnesi. All'ECG si riscontra presenza di bassi voltaggi periferici, emblocco di branca anteriore sinistro e pseudo-necrosi anteriore. Esami ematochimici ed elettroforesi sierica ed urinaria nella norma. Viene prescritto ecocardiogramma che mostra ipertrofia simmetrica del ventricolo sinistro, del ventricolo destro e del setto. Viene effettuata una biopsia endomiocardica che riscontra: "Miocellule di dimensioni aumentate, talora frammentate ed atrofiche; nell'interstizio miocardico è presente una sostanza eosinofila, amorfa, omogenea". Alla luce del quadro clinico e di quello istologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- A: Amiloidosi cardiaca
- B: Miocardite cronica
- C: Fibrosi secondaria a pregresso evento ischemico
- D: Cardiomiopatia aritmogena
- E: Cardiomiopatia ipertrofica

CC: Il quadro ci mostra un paziente con un'ipertrofia ventricolare sia a destra che a sinistra senza storia di ischemia o storia di miocardite (per questo escludo l'evento ischemico e la miocardite cronica). Non segni di aritmie o familiarità o alterazioni che coinvolgono il ventricolo di destra (per questo escludo l'aritmogena) e la biopsia mi indica una sostanza eosinofila, amorfa, omogenea presente nell'interstizio (per questo escludo la Cardiomiopatia ipertrofica)

Difficoltà: Difficile

Domanda 111: (codice domanda: ssm2023551)



Donna, 23 anni, da circa due mesi presenta nodulo del quadrante superiore interno della mammella sinistra che, riferisce, è in accrescimento. Quando l'assistita si presenta al curante il nodulo è di 2,2 cm, clinicamente a margini netti, mobile, di consistenza teso-elastica. Viene eseguita biopsia eco-guidata il cui esame istologico mostra: "Lesione fibroepiteliale a cellularità stromale diffusamente aumentata in assenza di atipie; proliferazione ghiandolare con note di iperplasia duttale senza atipie. È presente 1 mitosi/10 HPF". In base al quadro clinico e a quello istologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- A: Fibroadenoma
- B: Tumore filloide
- C: Carcinoma duttale infiltrante
- D: Adenoma tubulare
- E: Mixoma mammario

CC: La donna è giovane, quindi questo ci indirizza già di più verso una patologia benigna e non maligna, ma ci aiuta anche il fatto che sia mobile ed a margini netti al tatto. L'esame istologico è inoltre dirimente per la diagnosi differenziale.

Difficoltà: Difficile

Domanda 112: (codice domanda: ssm2023552)

Una donna di 54 anni, durante esami ematochimici di routine, presenta un incremento del TSH con valori normali di fT3 e fT4. Viene effettuata ecografia tiroidea che mostra la presenza di noduli multipli, tra i quali un nodulo del lobo sinistro, del diametro massimo di 18 mm, con aspetto ipoecogeno, a bordi irregolari, con presenza di microcalcificazioni. Viene effettuato agoaspirato di tale nodulo che mostra all'esame citologico: "Numerose emazie associate a gruppi di cellule con nuclei ingranditi, ovali, talora sovrapposti, che mostrano incisure e pseudoinclusioni nucleari". In base al quadro clinico e citologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

- A: Carcinoma papillifero
- B: Nodulo colloideo-cistico
- C: Nodulo iperplastico
- D: Carcinoma midollare
- E: Adenoma follicolare

CC: L'aspetto ecografico del nodulo del lobo sinistro, ipoecogeno, a bordi irregolari e dotato di microcalcificazioni, è fortemente sospetto per un nodulo con caratteristiche maligne; in particolare, la presenza di microcalcificazioni suggerisce la presenza di un carcinoma papillare della tiroide. Quest'ultimo è il più frequente tra tutti gli istotipi



tumoriali (75-85% del totale) e dal punto di vista citologico è caratterizzato da un'architettura papillare, dai corpi psammomatosi (responsabili del riscontro delle microcalcificazioni a livello ecografico), da nuclei otticamente vuoti, chiari, e con cromatina rarefatta (anche definiti occhi di orfanella Annie), da pseudoinclusioni nucleari, espressione di invaginazioni del citoplasma nel nucleo, e da incisure nucleari. Opzione A corretta. Tra le altre opzioni, il nodulo colloideo-cistico, il nodulo iperplastico e l'adenoma follicolare si riferiscono a proliferazioni di natura follicolare di natura benigna, che non presentano caratteristiche sospette dal punto di vista ecografico e non presentano caratteristiche citologiche tipiche (opzioni B, C ed E errate). Ricordiamo che la diagnosi differenziale tra adenoma e carcinoma follicolare (non presente tra le opzioni) si effettua valutando un'eventuale infiltrazione capsulare o un'invasione vascolare. Il carcinoma midollare, un tumore maligno della tiroide raro ad origine dalle cellule parafollicolari o cellule C, spesso non presenta caratteristiche ecografiche peculiari e sospette per un nodulo maligno; si associa alla produzione di calcitonina, che pertanto è utile dosare nel sangue in caso di riscontro di un nodulo tiroideo. Le caratteristiche citologiche sono eterogenee, pertanto in caso di sospetto è utile il dosaggio della calcitonina su liquido di lavaggio da agoaspirato su nodulo tiroideo. Opzione D errata.

Difficoltà: Facile

Domanda 113: (codice domanda: ssm2023553)

Uomo di 72 anni, fumatore con storia di etilismo, sviluppa una progressiva difficoltà nella deglutizione. All'esame obiettivo non vengono riscontrati segni particolari; si decide quindi di sottoporre il paziente ad EGDS durante la quale si riscontra la presenza di una lesione a placca, centralmente erosa, di 1 cm di diametro massimo, al livello del terzo medio dell'esofago su cui si effettua una biopsia; l'esame istologico mostra: "Proliferazione costituita da cellule di grandi dimensioni, con citoplasma abbondante ed eosinofilo e con nuclei di dimensioni aumentate e nucleolo prominente". In base al quadro clinico ed a quello istologico, quale è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

A: Carcinoma squamocellulare

B: Adenocarcinoma

C: Infezione da Citomegalovirus

D: Infezione fungina

E: Ulcera eosinofila

CC: Siamo di fronte ad una lesione dell'esofago in un paziente con disfagia e storia di etilismo e tabagismo. Ricordiamo che tali stili di vita costituiscono il fattore di rischio principale per il carcinoma squamocellulare dell'esofago, mentre la Malattia da Reflusso



Gastro esofageo con Esofagite eretica o Esofago di Barrett costituiscono i principali fattori di rischio per l'adenocarcinoma. Inoltre la localizzazione ai due terzi superiori è più tipica del Carcinoma squamocellulare, mentre l'adenocarcinoma è tipicamente localizzato ai quadranti inferiori. Le altre opzioni sono meno probabili e non pienamente compatibili col quadro clinico.

Difficoltà: Media

Domanda 114: (codice domanda: ssm2023554)

Un uomo di 22 anni giunge in Pronto Soccorso, presenta febbre oltre i 38,5°C, rigidità nucale e forte cefalea. Viene eseguita una rachicentesi e alla lettura microscopica del vetrino, nel liquor cefalo-rachidiano si evidenziano numerosi polimorfonucleati e diplococchi Gram negativi. Quale tra i seguenti microrganismi è il probabile responsabile dell'infezione?

- A: *Neisseria meningitidis*
- B: *Staphylococcus aureus*
- C: *Streptococcus pneumoniae*
- D: *Escherichia coli*
- E: *Streptococcus agalactiae*

CC: Il paziente del quadro clinico presenta una meningite batterica (liquor con PMN). In base all'età (22 anni) l'eziologia più comune è rappresentata da *Neisseria meningitidis* e *Streptococcus pneumoniae*. Tra le alternative proposte, solo le neisserie appaiono al microscopio come diplococchi G-. *Streptococcus agalactiae* ed *Escherichia coli* sono comuni fino ai 23 mesi mentre l'eziologia stafilococcica è tipica principalmente post interventi neurochirurgici.

Difficoltà: Facile

Domanda 115: (codice domanda: ssm2023555)

Una donna di 30 anni, alle prime settimane di gravidanza, ha eseguito varie indagini di laboratorio ed è risultata negativa alla ricerca di anticorpi anti-Toxoplasma gondii. Quale raccomandazione del proprio ginecologo non può mancare, per la prevenzione dell'infezione materno-fetale?

- A: Evitare il consumo di carne cruda o poco cotta
- B: Evitare il contatto con cani randagi
- C: Evitare di frequentare ambienti sovra-affollati
- D: Evitare il consumo di verdura cotta
- E: Usare repellenti per evitare punture di zanzara



CC: In caso di negatività anticorpale all'agente patogeno *Toxoplasma* sono necessari i seguenti interventi di prevenzione primaria al fine di prevenire l'infezione primaria durante la gravidanza. Questi sono: cuocere sempre molto bene le carni prima del consumo, evitare consumo di carni crude o poco cotte, salumi crudi, frutti di mare crudi, latte non pastorizzato, uova crude; lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo; evitare il contatto con il gatto e le sue feci; lavare sempre le mani prima di mangiare e dopo aver toccato carni crude, frutta e verdura non lavata.

Difficoltà: Facile

Domanda 116: (codice domanda: ssm2023556)

Una giovane donna di 20 anni, agli esami di controllo eseguiti per astenia profonda, presenta un emocromo con emoglobina 8,5 g/dL, MCV 64 fL e piastrine 500 x 10⁹/L. All'anamnesi riferisce probabile beta Talassemia Minor e flussi mestruali molto abbondanti. Quale tra le seguenti procedure è la più adeguata?

A: Si esegue la valutazione della sideremia, transferrinemia e ferritinemia e, se presente carenza di ferro, si prescrive terapia marziale; successivamente si procede con la valutazione dell'elettroforesi delle emoglobine

B: Nei portatori di beta Talassemia Minor non è opportuno alcun trattamento marziale per cui si prescrive il dosaggio della vitamina B12 e dell'acido folico per l'eventuale supporto con vitamine emoaattive

C: Si contatta lo specialista Ematologo e il Servizio Trasfusionale per il supporto trasfusionale urgente con emazie

D: Si prescrive subito l'elettroforesi delle emoglobine per porre diagnosi certa di beta Talassemia Minor e si invia quindi la paziente dallo specialista Ematologo

E: Si prescrive una gastroscopia e una rettocolonscopia nell'ipotesi di una anemizzazione da perdita cronica di sangue

CC: Domanda solo apparentemente complessa. In base all'anamnesi ci troviamo davanti ad una giovane donna con flussi mestruali abbondanti e la presenza di anemia microcitica moderata-grave. In assenza di instabilità emodinamica si deve effettuare una terapia marziale e solo successivamente effettuare una valutazione con elettroforesi delle isoforme dell'emoglobina. La beta Talassemia Minor da sola non giustifica una tale anemizzazione e spesso nelle donne in età fertile con cicli mestruali abbondanti si accompagna a sideropenia. In assenza di instabilità emodinamica non è indicata terapia trasfusionale urgente. In base all'anamnesi (flussi mestruali abbondanti) e alla giovane età della paziente un sanguinamento gastrointestinale è meno probabile e non è indicata l'esecuzione in prima linea di gastroscopia o coloscopia.

Difficoltà: Facile



Domanda 117: (codice domanda: ssm2023557)

La diagnosi di fenilchetonuria avviene solitamente nell'ambito di:

A: Un programma di screening neonatale basato sulla determinazione dei livelli plasmatici di fenilalanina misurati almeno 48 ore dopo la nascita

B: Un programma di screening neonatale basato sulla valutazione dell'attività dell'enzima fenilalanina idrossilasi epatico dopo la comparsa dei sintomi caratteristici mediante valutazioni biochimiche e molecolari

C: Approcci diagnostici prenatali basati sulla determinazione delle mutazioni responsabili nel DNA fetale

D: Approcci diagnostici neonatali effettuati selettivamente su figli di pazienti affetti dalla malattia

E: Approcci diagnostici neonatali effettuati selettivamente su figli di pazienti affetti da questa o da altre malattie del metabolismo degli aminoacidi

CC: La fenilchetonuria è una patologia metabolica ereditaria caratterizzata da un difetto della fenilalanina idrossilasi, enzima che si occupa di degradare la fenilalanina. Questo porta ad un accumulo dei cataboliti della fenilalanina nell'organismo (alcuni di questi saranno misurabili anche nelle urine, da cui il nome della patologia) con conseguente danno neurologico grave. Bisogna ricordare che la fenilchetonuria è una di quelle condizioni sottoposte a screening obbligatorio per tutti i neonati alla nascita (a circa 48 ore di vita). Tale screening si basa sulla misurazione dei livelli di fenilalanina sul sangue del neonato.

Difficoltà: Media

Domanda 118: (codice domanda: ssm2023558)

Il vaccino antimorbillo è:

A: Costituito da virus vivi e attenuati

B: Combinato con il vaccino anti-pertosse e anti-rotavirus

C: Ottenuto mediante la tecnica del DNA ricombinante

D: Costituito da virus inattivati

E: Costituito da subunità virali

CC: Il vaccino anti-morbillo è prodotto attraverso tecnologie che modificano il patogeno rendendolo non patogeno, ma mantenendo delle componenti antigeniche in grado di stimolare la difesa immunitaria. Altri vaccini prodotti con questa tecnologia sono: rosolia, parotite, varicella, febbre gialla e micobatterio della tubercolosi.

Difficoltà: Facile



Domanda 119: (codice domanda: ssm2023559)

La tossina tetanica:

- A: E' una neurotossina che causa paralisi spastica potenzialmente letale
- B: E' una neurotossina che causa paralisi flaccida potenzialmente letale
- C: E' una enterotossina che causa intossicazioni alimentari
- D: Viene prodotta da spore di Clostridium tetani
- E: Induce un'efficace risposta immunitaria dopo la guarigione clinica

CC: La tetanospasmina (tossina tetanica) è prodotta dalle forme vegetative del C.tetani (opzione D errata) e causa paralisi spastica a differenza della tossina botulinica che invece causa paralisi flaccida (opzione B errata). Infine, il tetano non conferisce immunità permanente dopo la guarigione clinica.

Difficoltà: Facile

Domanda 120: (codice domanda: ssm2023560)

Indicare, quale delle seguenti affermazioni concernenti Il Servizio Sanitario Nazionale è corretta:

- A: I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza
- B: La definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) compete alle Regioni
- C: Le Aziende Sanitarie Locali sono state istituite con la legge 833/1978
- D: I medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta sono professionisti "dipendenti" dal Servizio Sanitario Regionale
- E: Nel 2001 una legge costituzionale ha attribuito alle Regioni potere esclusivo in tema di sanità

CC: I LEA vengono definiti a livello nazionale attraverso dei DPCM, di cui il primo è quello del 2001 che li istituisce, mentre l'ultimo aggiornamento risale al 2017; i LEA individuano le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse). Le ASL sono state istituite nel D. Lgs. 502 del 1992, che insieme al 517/93 definisce nel dettaglio l'organizzazione del SSN istituito con la legge 833/78. MMG e PLS sono invece dei liberi professionisti convenzionati con il SSN ma non sono attualmente inquadrati come dipendenti.

Difficoltà: Facile



Domanda 121: (codice domanda: ssm2023561)

Tra gli studi epidemiologici:

- A: Quelli di coorte si basano sull'osservazione nel tempo di soggetti esposti e non esposti ad un fattore di rischio
- B: Quelli di coorte consentono di calcolare la prevalenza della malattia negli esposti e nei non esposti ad un fattore di rischio
- C: Quelli caso-controllo consentono di calcolare l'incidenza della malattia negli esposti e nei non esposti ad un fattore di rischio
- D: Quelli caso-controllo non sono indicati per le malattie rare
- E: Quelli trasversali sono studi di incidenza

CC: Degli studi epidemiologici è fondamentale inquadrare le principali differenze e caratteristiche per rispondere correttamente a domande come questa. Gli studi trasversali sono studi puntuali, che quindi non hanno una componente di tempo duratura ma "fotografano" la situazione epidemiologica in un determinato momento; conoscendo quindi le definizioni di incidenza e prevalenza possiamo dedurre come siano studi di prevalenza (risposta E errata). Gli studi di incidenza sono invece quelli longitudinali, come quello di coorte e il caso-controllo; mentre il primo parte da due gruppi (coorti) divisi in base all'esposizione al fattore di rischio e, in maniera prospettica, indaga lo sviluppo o meno di patologia (quindi la direzione è quella che va dal FdR alla malattia), il secondo divide il campione in due gruppi a seconda che i soggetti siano malati (casi) o sani (controlli) e va ad indagare, in maniera tendenzialmente retrospettiva, la precedente esposizione o meno al fattore di rischio (quindi va dalla malattia al FdR).

Difficoltà: Facile

Domanda 122: (codice domanda: ssm2023562)

Cosa si intende con il termine "rischio" nell'ambito della Medicina del Lavoro?

- A: La probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
- B: La proprietà intrinseca di un determinato fattore di provocare un danno alla salute
- C: Una qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più fattori di rischio
- D: Abbreviazione con la quale si identifica un documento di valutazione dei rischi
- E: Qualsiasi danno alla salute provocato da un'esposizione nociva

CC: La proprietà intrinseca di un determinato fattore di provocare un danno alla salute rappresenta la definizione di *pericolo*, mentre per rischio si intende la probabilità del



raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Una *situazione pericolosa* è rappresentata invece da qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più fattori di rischio. L'abbreviazione con la quale si identifica un documento di valutazione dei rischi è la "DVR". Infine, il cosiddetto *danno alla salute* è rappresentato da qualsiasi danno alla salute provocato da un'esposizione nociva.

Difficoltà: Facile

Domanda 123: (codice domanda: ssm2023563)

Quali tra le seguenti definizioni riguardo l'ipoacusia da rumore è corretta?

- A: E' di tipo percettivo, bilaterale e simmetrica
- B: E' di tipo percettivo e generalmente asimmetrica
- C: E' di tipo trasmissivo, bilaterale e simmetrica
- D: E' di tipo trasmissivo e generalmente asimmetrica
- E: E' di tipo centrale e generalmente asimmetrica

CC: Con ipoacusia da rumore s'intende la perdita dell'udito causata dall'esposizione cronica a forti rumori (es. in ambiente lavorativo) oppure a un forte trauma acustico (es. esplosione di un petardo). La riconosciamo in quanto è bilaterale e simmetrica (al contrario di quelle monolaterali come nel caso di un danno alla catena ossicolare). Il trattamento dell'ipoacusia professionale da rumore si concentra sulla riduzione del fastidio causato dagli acufeni con l'assunzione di farmaci vasoattivi e glicocorticoidi.

Difficoltà: Facile

Domanda 124: (codice domanda: ssm2023564)

Arriva all'osservazione medica un bambino di 3 anni accompagnato dai genitori che riferiscono caduta accidentale dalle scale. Il bambino appare spaventato e all'ispezione i sanitari notano la presenza di multiple ecchimosi in fasi cromatiche differenti sulla regione dorsale di entrambi gli avambracci. Gli esami radiologici mostrano esiti di fratture anche "a legno verde" agli arti. I sanitari si consultano in merito alla necessità di informare l'autorità giudiziaria. Tale obbligo grava:

- A: Su chiunque, nell'esercizio della professione sanitaria, abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio
- B: Solo sul medico che abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio
- C: Solo sul medico che abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile a querela della persona offesa



D: Su chiunque, nell'esercizio della professione sanitaria, abbia prestato la propria opera o assistenza, nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto procedibile a querela della persona offesa

E: L'obbligo non sussiste in quanto i genitori sarebbero perseguibili penalmente

CC: Domanda già presentata, con caratteristiche analoghe, in passato. Il quesito richiede implicitamente di ricordare la definizione di "referto" e "rapporto". nella fattispecie, qui si parlava del referto, che riguarda chiunque eserciti una professione sanitaria e presti la propria opera o assistenza nei casi, come questo (sospetto maltrattamento di minore) che abbiano i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. In particolare, si è obbligati a informare l'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica) entro 48 ore o immediatamente: esiste una condizione esimente (a differenza del rapporto, che non ne ha), che è quella di esporre l'assistito a procedimento penale. In questo caso l'assistito è il bambino, nonchè soggetto vittima di presunti maltrattamenti, per cui bisogna informare l'Autorità Giudiziaria. Le opzioni troppo assertive, contenenti "solo", di solito possono essere escluse.

Difficoltà: Facile

Domanda 125: (codice domanda: ssm2023565)

Una persona maggiorenne viene trasportata con urgenza in Pronto Soccorso a seguito di incidente stradale. I medici riscontrano la necessità di intervenire con urgenza perché gli accertamenti hanno evidenziato un vasto ematoma intracranico. La persona è incosciente e non è in grado di prestare consenso. Quale tra i seguenti comportamenti è quello corretto?

A: Il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, riconoscendo la sussistenza dello "stato di necessità"

B: Il medico e i componenti dell'equipe sanitaria devono astenersi da qualsiasi cura finchè la persona non sia in grado di esprimere un valido consenso

C: Il medico segnala il caso alla Procura della Repubblica per ottenere l'autorizzazione ad intervenire

D: Il medico e l'equipe sanitaria intervengono solo con il consenso di eventuali familiari presenti

E: Il medico interviene chirurgicamente anche in presenza di Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) contrarie all'intervento confermate dal fiduciario

CC: Lo stato di necessità nelle condizioni in cui la vita del paziente sia messa in pericolo impone ai sanitari di agire. Esso è regolamentato dall'art.54 del CP: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal



pericolo attuale di un danno grave alla persona”...In questo caso, non intervenire equivarrebbe ad omettere il soccorso.

Difficoltà: Facile

Domanda 126: (codice domanda: ssm2023566)

Per un gruppo di 500 pazienti è stato calcolato un rischio relativo (RR) di 5,65 rispetto all'esposizione ad uno specifico fattore di rischio. Ciò significa che la probabilità di sviluppare una certa malattia è:

- A: Molto alta quando l'individuo è esposto al fattore di rischio
- B: Molto bassa quando l'individuo è esposto al fattore di rischio
- C: Nulla quando l'individuo è esposto al fattore di rischio
- D: Equivalente tra l'essere e il non essere esposti
- E: Più bassa negli esposti rispetto ai non esposti (fattore protettivo)

CC: Per RR si intende il rapporto tra la probabilità che si verifichi un evento in un gruppo esposto (a un trattamento, un fattore di rischio, un fattore protettivo), e la probabilità che si verifichi lo stesso evento in un gruppo di non esposti (allo stesso trattamento, fattore di rischio, fattore protettivo) e si calcola come: rischio negli esposti/rischio nei non esposti. Il RR indica la forza dell'associazione fra l'esposizione (o trattamento) e l'esito ed è sempre un numero positivo. Se $RR = 1$ significa che il rischio che si verifichi l'evento nei 2 gruppi è uguale: in questo caso non c'è associazione fra l'esposizione e l'esito. Se $RR < 1$ significa che il rischio che si verifichi un evento nel gruppo dei trattati o esposti è inferiore rispetto al gruppo di controllo: in questo caso l'esposizione è protettiva. Se $RR > 1$ significa che il rischio del verificarsi dell'evento nel gruppo dei trattati o esposti è superiore rispetto al gruppo di controllo: in questo caso l'esposizione è dannosa. Quest'ultimo è quindi il caso della domanda, per cui la probabilità di sviluppare la malattia in questione è molto alta quando l'individuo è esposto al FdR.

Difficoltà: Facile

Domanda 127: (codice domanda: ssm2023567)

Qual è il primo provvedimento da adottare in un paziente in coma con ostruzione delle vie aeree per perdita del tono muscolare al fine di ripristinarne la pervietà?

- A: Iperestensione del capo e sublussazione della mandibola
- B: Ventilazione manuale con maschera facciale
- C: Posizionamento di maschera laringea
- D: Curarizzazione ed intubazione oro-tracheale
- E: Esecuzione di cricotiroidotomia



CC: La manovra di iperestensione del capo con sublussazione della mandibola, in assenza di traumi cervicali, consente di disostruire le prime vie aeree del paziente, considerando che nel caso descritto questa è data dalla caduta all'indietro della lingua e dall'ipotonosi muscolare. Successivamente si può considerare la ventilazione bimanuale (per assicurare l'aderenza) con maschera, o l'utilizzo di altri presidi qualora la manovra non risulti sufficiente.

Difficoltà: Media

Domanda 128: (codice domanda: ssm2023568)

Un uomo di 28 anni, ASA1, deve essere sottoposto ad intervento di colecistectomia. Il paziente non ha subito precedenti interventi chirurgici. In sala operatoria dopo somministrazione di profilassi antibiotica e di Ondansetron l'anestesista procede ad induzione dell'anestesia con Propofol, Fentanyl, Cisatracurium, anestesia topica delle prime vie aeree con lidocaina. Dopo l'intubazione tracheale compaiono orticaria, angioedema delle palpebre e delle labbra, ipotensione e tachicardia. Quale delle seguenti classi di farmaci è più frequentemente causa di reazione anafilattica in corso di anestesia generale?

- A: Miorilassanti
- B: Anestetici locali
- C: Oppioidi
- D: Ipnotici
- E: Antiemetici

CC: Bisogna ricordare che tra i farmaci impiegati per l'induzione di una normale anestesia generale i curari (miorilassanti) liberano quantità notevoli di istamina, per cui sono piuttosto allergogeni. A seguire, si ritrovano gli antibiotici. In questa domanda si potevano escludere gli anestetici locali poichè non menzionati. In generale, per quanto concerne il rischio allergico in anestesia, è fondamentale condurre una buona valutazione allergologica pre-anestesia, che però non può garantire la sicurezza diagnostica assoluta. Allo stesso modo, nessuna premedicazione consente di evitare una reazione anafilattica, ma gli anti H1 modificano significativamente la reattività.

Difficoltà: Media

Domanda 129: (codice domanda: ssm2023569)

Un uomo di 30 anni, per altro sano, deve essere sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica. Quale tra le seguenti procedure deve essere effettuata preliminarmente per la riduzione del rischio perioperatorio:

- A: Valutazione anestesilogica (accurata anamnesi ed esame obiettivo)



B: Esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria ed emogasanalisi

C: ECG e consulenza cardiologica

D: Assetto emocoagulativo completo

E: Screening sierologico per anticorpi anti-HBV, anti-HCV e anti-HIV

CC: Il colloquio preoperatorio con il medico anestesista è fondamentale per valutare eventuali difficoltà di intubazione del paziente, qualora si proceda con una anestesia generale, raccogliere dettagliatamente la sua anamnesi patologica, farmacologica (specialmente nel caso in cui il paziente assuma farmaci anticoagulanti o antiaggreganti che vanno sospesi con differenti tempistiche prima dell'intervento), allergologica al fine di stabilire una corretta premedicazione e limitare per quanto possibile l'insorgenza di complicanze pre-peri e post operatorie. Infine, è fondamentale in questa fase acquisire il consenso del paziente, dopo aver dettagliatamente spiegato rischi e benefici correlati alla procedura. In generale, per soggetti sani è sufficiente eseguire un emocromo di controllo; per soggetti con anamnesi positiva per patologie cardiovascolari si esegue un ECG di controllo refertato dallo specialista; per soggetti con patologie respiratorie o forti fumatori è utile associare una RX torace; per interventi con rischi particolari o necessitanti di trasfusioni si esegue lo screening sierologico. Il paziente descritto nella domanda però non rientra in nessuno di questi casi, per cui la visita anestesiológica sarà sufficiente.

Difficoltà: Facile

Domanda 130: (codice domanda: ssm2023570)

Uomo di 30 anni, cade dalla scala mentre sta potando un albero. Viene chiamato il 118 che lo trasporta al Pronto Soccorso. All'arrivo in Pronto Soccorso è vigile e cosciente, GCS 15/15. Non presenta deficit di lato. Lamenta un forte dolore all'emitorace destro dove all'esame obiettivo sono evidenti ematomi multipli. All'auscultazione del torace il murmure vescicolare è ridotto a destra. I suoi parametri vitali sono: SpO₂ 92% in aria ambiente, FR 30 atti/min, PA 120/70 mmHg, FC 100 bpm, ritmo sinusale, emoglobina 13,5 g/dL. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

A: Pneumotorace monolaterale

B: Shock emorragico da rottura di milza

C: Shock spinale da frattura mielica

D: Emotorace massivo dx

E: Angina pectoris

CC: L'esame obiettivo pone segni inequivocabili di pneumotorace monolaterale: il murmure vescicolare ridotto solo a destra, il dolore. Le opzioni contenenti lo shock



potevano essere eliminate in quanto i pv del paziente sono nella norma, fatta eccezione per la saturazione ridotta, così come l'emotorace massivo (non è anemizzato in maniera troppo rilevante). Considerando la dinamica poteva essere esclusa anche l'angina.

Difficoltà: Facile

Domanda 131: (codice domanda: ssm2023571)

Una paziente di 62 anni viene sottoposta in anestesia generale al posizionamento di uno stent ureterale per calcolosi renale. Non si registrano complicanze intraoperatorie. Al risveglio presenta brivido scuotente, tachipnea, tachicardia. I parametri vitali sono: GCS 14/15 SpO2 99% in aria ambiente, PA 140/100 mmHg, temperatura di 39,5 gradi centigradi. Quale tra le seguenti è la diagnosi più probabile?

- A: Urosepsi
- B: Broncospasmo
- C: Nausea e vomito post-operatorio (PONV)
- D: Ipertermia maligna
- E: Shock anafilattico

CC: Gli elementi chiave di questa domanda erano: brivido scuotente subito dopo la procedura di posizionamento dello stent, tachipnea e tachicardia. Potevano essere esclusi il broncospasmo (non segni di dispnea), la PONV (non si menziona emesi), l'ipertermia maligna (quadro molto più accentuato, solitamente insorge pochi minuti dopo l'esposizione ad anestetici volatili o succinilcolina, mentre la paziente non ha riportato complicanze intraoperatorie) e lo shock anafilattico, poichè i parametri vitali sono tutto sommato stabili e compatibili con la febbre.

Difficoltà: Facile

Domanda 132: (codice domanda: ssm2023572)

Una donna di 32 anni, si reca in Pronto Soccorso per cardiopalmo. APR negativa. All'esame obiettivo: GCS 15/15, SpO2 99% in aria ambiente, FR 29 minuto, PA 110/65 mmHg, FC 180 bpm. L'ECG mostra il seguente tracciato: tachicardia parossistica sopraventricolare da rientro nodale. Alla luce del quadro ECG e dei parametri vitali quale tra i seguenti è l'intervento terapeutico più appropriato?



A: Adenosina ev

B: Atropina ev

C: KCl ev

D: Cardioversione elettrica sincronizzata

E: Isoproterenolo ev

CC: L'esercizio poteva risolversi anche non leggendo l'ecg, la diagnosi infatti ci viene data dal testo, tachicardia parossistica sopraventricolare da rientro nodale. Il trattamento si basa sulla somministrazione di adenosina la quale somministrata per via endovenosa rapida, rallenta la conduzione a livello del nodo AV. Quest'azione può interrompere i circuiti di rientro che coinvolgono il nodo AV e ristabilire il ritmo sinusale in pazienti con tachicardie parossistiche sopraventricolari. Una volta che il circuito di rientro è stato interrotto la tachicardia si arresta e si ristabilisce il ritmo sinusale.

Difficoltà: Media

Domanda 133: (codice domanda: ssm2023573)

Un uomo di 70 anni deve essere operato d'urgenza per occlusione intestinale. Quale condotta è consigliata per ridurre il rischio di inalazione del contenuto gastrico all'induzione dell'anestesia generale?

A: Intubazione in sequenza rapida

B: Posizionamento di maschera laringea

C: Intubazione fibroscopica

D: Intubazione selettiva

E: Tracheostomia

CC: Il rischio di inalazione nei pazienti a stomaco pieno (quindi per antenomasia le gravide o i pazienti operati in regime di urgenza) è presente in particolare nelle fasi di



induzione (tra la perdita di coscienza ed il gonfiaggio della cuffia che assicura il tubo in posizione), intraoperatoria (rigurgiti passivi), postoperatoria (per insufficienza dei riflessi laringei). Si può effettuare una prevenzione mediante aspirazione gastrica, che però non assicura il totale svuotamento. Questa induzione in sequenza rapida prevede che si eviti di ventilare manualmente il paziente (per ridurre il rischio di insufflare lo stomaco e aumentare la pressione gastrica), posizionare un sondino gastrico, effettuare la manovra di Sellick (pressione cricoidea per favorire l'intubazione) e garantire l'intervallo più breve fra perdita di coscienza e messa in sicurezza delle vie aeree.

Difficoltà: Media

Domanda 134: (codice domanda: ssm2023574)

Una donna di 78 anni deve essere sottoposta a chirurgia ortopedica per riduzione di una frattura distale della tibia. L'anestesista decide di eseguire un blocco del nervo sciatico popliteo con 15 mL di bupivacaina 0,5% e un blocco del nervo femorale con 12 mL di bupivacaina 0,5%. In assenza momentanea di ecografo i blocchi vengono eseguiti con elettro-neurostimolatore. Alla comparsa di agitazione psicomotoria della paziente viene somministrato Midazolam 1 mg. A seguire la paziente riferisce sapore metallico, quindi sviluppa una crisi convulsiva. In base al sospetto clinico, oltre ad assicurare una adeguata gestione delle vie aeree è indicato procedere a:

- A: Somministrazione di emulsione lipidica 20% per via endovenosa
- B: Somministrazione di 100 mL di ipertonica al 3% nel sospetto di ipertensione endocranica
- C: Infusione continua di dexmedetomidina
- D: Somministrazione di levetiracetam
- E: Somministrazione di fenobarbitale

CC: Argomento abbastanza quotato di Anestesia: la LAST (Local Anaesthetic Systemic Toxicity), che insorge a causa dell'iniezione accidentale del farmaco in circolo. Essa è caratterizzata da sintomi inerenti a neurotossicità (fase eccitatoria, con intorpidimento peiorale, sapore metallico, tinnito, vertigini e fase depressiva con coma e depressione respiratoria) e cardiotoxicità (fase eccitatoria, con ipertensione e tachicardia e fase depressiva con ipotensione e depressione miocardica). Basta riconoscerla e trattarla tempestivamente con infusione di Intralipid al 20% ev.

Difficoltà: Facile

Domanda 135: (codice domanda: ssm2023575)

La riabilitazione propriocettiva si prefigge:



- A: Il recupero del controllo motorio tramite la stimolazione di afferenze cinestetiche
- B: Il recupero della sensibilità esteroceettiva in generale
- C: Di ridurre il paziente al recupero dell'emilato plegico dopo un ictus
- D: Il recupero delle sensibilità profonde tramite la stimolazione di afferenze termo-dolorifiche
- E: Il recupero della sensibilità esteroceettiva nell'emilato plegico del paziente dopo un ictus

CC: Difficoltà del quesito solo per i vari fattori confondenti fra le opzioni: considerando che la definizione di propriocezione è la capacità di percepire e riconoscere il proprio corpo nello spazio, le opzioni inerenti a un emilato sarebbero limitanti in questo senso. Pertanto, escludendo la sensibilità esteroceettiva generale, rimaneva l'opzione corretta.

Difficoltà: Media

Domanda 136: (codice domanda: ssm2023576)

Un uomo di 80 anni, sottoposto ad impianto di artroprotesi d'anca per coxartrosi sinistra, viene trasferito dal reparto di Ortopedia al reparto di Medicina Riabilitativa per iniziare la riabilitazione. In anamnesi sono presenti: cardiopatia ischemica cronica e disturbi cognitivi con autonomia ancora conservata, ma con saltuari episodi di disorientamento, specialmente notturni. Al suo arrivo il paziente presenta dolore intenso a livello dell'anca operata ed il personale infermieristico riferisce che la notte precedente, durante un episodio di disorientamento, il paziente ha tentato più volte di scavalcare le sponde del letto. Clinicamente l'arto inferiore sinistro si presenta tumefatto alla radice della coscia, accorciato rispetto al controlaterale, extraruotato, con difficoltà alla mobilizzazione passiva che provoca intenso dolore. Non sono presenti deficit vascolo-nervosi periferici obiettabili. Come è più opportuno procedere?

- A: Richiedere una radiografia dell'anca urgente per il sospetto di una lussazione dell'impianto protesico
- B: Non si deve prendere alcun provvedimento, è normale che dopo un intervento l'arto sia gonfio e dolente
- C: Raccomandare al fisioterapista una intensa mobilizzazione per recuperare l'articolazione dell'anca
- D: Richiedere un ecodoppler venoso dell'arto inferiore sinistro urgente per escludere la presenza di trombosi venosa profonda
- E: Richiedere un angio-RM urgente per il sospetto di una lesione dell'arteria femorale

CC: Questa domanda poteva essere risolta tramite un ragionamento di esclusione, considerando che il paziente, durante quello che ha le caratteristiche di un delirium



post operatorio, ha provato a extraruotare eccessivamente l'arto appena operato: pertanto, esclusi i segni di deficit vascolonervoso (che facevano escludere due opzioni) ed il fatto di dover intensificare il movimento tramite fisioterapia, o ancora il fatto che questo quadro fosse normale, si poteva giungere alla risposta corretta. Il vero fattore quindi su cui concentrarsi è l'episodio di aver scavalcato le spondine del letto (movimento lussante l'anca, da evitare assolutamente, di flessione ed intrarotazione) e la presentazione dell'arto accorciato ed extraruotato.

Difficoltà: Facile

Domanda 137: (codice domanda: ssm2023577)

Un uomo di 36 anni asmatico si presenta in Pronto Soccorso per una esacerbazione grave dell'asma. La sintomatologia migliora dopo somministrazione di salbutamolo per via inalatoria. Quale dei seguenti meccanismi prioritariamente può spiegare l'effetto farmacologico dei farmaci beta-2-agonisti?

- A: Aumento della AMP ciclico nelle cellule muscolari lisce tracheo-bronchiali
- B: Azione sui recettori purinergici nelle cellule muscolari lisce tracheo-bronchiali
- C: Riduzione della clearance muco-ciliare
- D: Riduzione del tono simpatico
- E: Aumento della performance diaframmatica

CC: L'azione farmacologica dei beta-2 agonisti si esplica mediante aumento della AMP ciclico nelle cellule muscolari lisce tracheo bronchiali. Ciò determina l'effetto di rilassamento della muscolatura bronchiale e dilatazione vie aeree necessari in caso di esacerbazione grave dell'asma.

Difficoltà: Media

Domanda 138: (codice domanda: ssm2023578)

Un uomo di 62 anni è in trattamento con furosemide, digossina e ramipril per uno scompenso cardiaco a bassa frazione di eiezione. Sebbene la terapia abbia migliorato la performance cardiaca e la qualità di vita, il soggetto si reca dal proprio medico curante lamentandosi della difficoltà ad urinare nelle ultime 24 ore. Il medico, non rilevando segni di deplezione intravascolare di volume, aumenta la dose di furosemide. Tuttavia, a distanza di 6 ore, non ci sono miglioramenti. Il paziente stava assumendo autonomamente ibuprofene 1200 mg/die per la comparsa di dolore alla gamba durante la deambulazione. Quale dei seguenti meccanismi è più probabilmente responsabile dell'oliguria?

- A: Riduzione del filtrato glomerulare a causa della terapia con ibuprofene



B: Riduzione del filtrato glomerulare a causa della terapia con digossina

C: Peggioramento dello scompenso cardiaco nonostante la terapia

D: Riduzione della secrezione di renina mediata da furosemide

E: Ipokaliemia indotta da furosemide

CC: Bisogna ricordare i profili di tossicità dei farmaci qui presentati. Tra questi ad avere maggiore tossicità renale in un paziente predisposto è l'ibuprofene in base all'inibizione delle COX responsabili della vasoregolazione renale. Il peggioramento di uno scompenso cardiaco a bassa gittata può provocare una riduzione del filtrato glomerulare e oliguria, ma è un'opzione meno probabile vista l'anamnesi farmacologica. Furosemide e digossina non causano come comune effetto collaterale insufficienza renale.

Difficoltà: Difficile

Domanda 139: (codice domanda: ssm2023579)

Un uomo di 52 anni, a seguito di un infarto miocardico, da 2 mesi è in terapia con un regime poli-farmacologico definito dal cardiologo. A successivi controlli presenta un incremento delle transaminasi circa 3-5 volte superiore ai valori normali di riferimento. Quale tra i seguenti farmaci è più probabile abbia causato l'alterazione dei parametri di laboratorio epatici?

A: Atorvastatina

B: Atenololo

C: Warfarin

D: Clopidogrel

E: Isosorbide dinitrato

CC: Bisogna ricordare che tra i profili di tossicità delle statine vi sono l'epatotossicità e la miopatia, entrambi possibilmente responsabili di un rialzo delle transaminasi.

Difficoltà: Media

Domanda 140: (codice domanda: ssm2023580)

Un paziente è affetto da una malattia a trasmissione autosomica recessiva che colpisce 1 individuo su 10.000 nella popolazione generale (frequenza del portatore sano nella popolazione generale 1/50). Suo fratello sano sposa una donna non consanguinea. Che rischio hanno come coppia di avere un figlio affetto da questa specifica patologia?

A: 1/300

B: 1/600

C: 1/900



D: 1/1800

E: 1/100

CC: Domanda non banale ma affrontabile se si conoscono bene le basi della trasmissione genetica delle malattie. Partiamo dai dati che abbiamo: se il fratello del soggetto in questione è affetto da patologia autosomica recessiva (aa) e il fratello è sano, vuol dire che i genitori (che qui non vengono identificati come malati) sono entrambi portatori sani del gene (Aa), e la tabella dei loro alleli per quel gene sarà come segue:

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Quindi, dato che il soggetto è sano e possiamo escludere che i suoi alleli siano "aa", il soggetto avrà $\frac{2}{3}$ di probabilità di essere portatore sano ($\frac{2}{3}$ Aa, $\frac{1}{3}$ AA).

Per la moglie invece, che non ha familiarità per la malattia, faremo riferimento alla frequenza del portatore sano nella popolazione generale: 1/50.

Ora che abbiamo le due probabilità dei coniugi di essere portatori sani (e quindi di presentare una tabella come quella riportata sopra), dobbiamo moltiplicarle e poi moltiplicare ulteriormente per $\frac{1}{4}$, che è la probabilità che l'eventuale prole sia affetta da malattia e quindi presenti un corredo "aa" (come si vede dalla tabella sopra).

Il calcolo sarà quindi: $\frac{2}{3} \times \frac{1}{50} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{600} = \frac{1}{300}$.

Difficoltà: Media

Se hai trovato la
nostra correzione
commentata interessante,
visita il nostro sito



Se invece pensi che il
test sia andato male,
**qui trovi la tua
seconda possibilità**